



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN
AKSES KESINAMBUNGAN PELAYANAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Tentang
Panduan Akses Kesenambungan Pelayanan Rumah Sakit

Disusun oleh :
Penanggung Jawab TIM AKP



(Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Akses Kesenambungan Pelayanan Rumah Sakit dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada. Panduan Akses Kesenambungan Pelayanan Rumah Sakit ini yang dipergunakan pada tahun 2025 meliputi system pelayanan yang terintegrasi dan berkesinambungan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Manajer Pelayanan Pasien ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Prima Husada.

Malang, 04 April 2025

Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN
PANDUAN AKSES KESINAMBUNGAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pengarah :

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

Pelaksana :

1. dr. Nur Mazidah
2. Afni Nuraini, S.Kep., Ns
3. Ratih Aji Suryamanjari, S.Kep., Ns
4. Murwani Suryaning Sapartinah, AMd. Kep
5. Ferianto Hendri Cahyono, AMd.Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL
LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
TIM PENYUSUN iii
DAFTAR ISI iv
PERATURAN DIREKTUR v
BAB I PENDAHULUAN 1
 1.1 PENDAHULUAN 1
 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1
 1.3 PENFERTIAN 1
BAB II RUANG LINGKUP 2
BAB III TATA LAKSANA 3
 3.1 SKRINING PASIEN DI RUMAH SAKIT 3
 3.2 REGISTRASI DAN ADMISI 7
 3.3 PEMULANGAN PASIEN 13
 3.4 RUJUKAN 18
BAB IV PENUTUP 27
LAMPIRAN 28

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR : 319.33/I-PND/IGD/IV/2025

TENTANG

PANDUAN AKSES KESINAMBUNGAN PELAYANAN RUMAH SAKIT
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Prima Husada, untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam hal kesinambungan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Akses Kesinambungan Pelayanan Rumah Sakit;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 (tentang Standarisai Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit;
 7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malangxx/-['/f v v
 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG TENTANG PANDUAN AKSES KESINAMBUNGAN PELAYANAN RUMAH SAKIT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- (2) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit;
- (3) Staf klinis adalah tenaga kesehatan yang memberikan asuhan langsung pada pasien;
- (4) Profesional Pemberi Asuhan adalah staf klinis profesional yang langsung memberikan asuhan kepada pasien;
- (5) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap asuhan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat penugasan klinisnya;
- (6) Perawat Penanggung Jawab Asuhan adalah perawat yang bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat penugasan klinisnya;
- (7) Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;
- (8) Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan;
- (9) Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan / atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostic.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Terdapat tenaga yang kompeten dan berwenang untuk bertanggung jawab pasien admisi, transfer dan rujuk
- (2) Proses triage dilakukan oleh staf yang kompeten dan berwenang
- (3) Semua staf klinis di igd yang memberikan pelayanan , asuhan adalah yang kompeten dan berwenang, dibuktikan dengan SPK dan RKK
- (4) Rumah sakit memiliki staff yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien.
- (5) Staff yang dimaksud dalam ayat 4 diatas adalah : Karu, Katim/PJ Shift
- (6) Terdapat staff pendamping yang kompeten dan berwenang yang bisa melakukan observasi kondisi pasien dan mencatat dalam form observasi .

BAB III

SKRINING

Pasal 3

- (1) Skrining di dalam maupun luar rumah sakit termasuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan / spesifik untuk menetapkan pasien diterima atau dirujuk;
- (2) Rumah sakit menerapkan proses skrining di dalam dan diluar rumah sakit dan terdokumentasi;
- (3) Skrining dilakukan untuk menilai apakah rumah sakit mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan pasien serta konsisten dengan misi rumah sakit;
- (4) Skrining dilaksanakan melalui kriteria triase, evaluasi visual atau pengamatan, atau hasil pemeriksaan fisis, psikologis, laboratorium klinis, atau diagnostik imaging;
- (5) Pada pelaksanaan skrining, dapat ditentukan tes atau bentuk penyaringan terhadap populasi pasien tertentu sebelum menetapkan pasien dapat dilayani;
- (6) Pasien diterima bila rumah sakit dapat memberi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dibutuhkan pasien;
- (7) Pada proses admisi pasien rawat inap dilakukan skrining kebutuhan pasien untuk menetapkan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif yang diprioritaskan berdasar atas kondisi pasien; Prioritas diberikan pada pelayanan terkait preventif, paliatif, kuratif dan rehabilitatif
- (8) Prioritas diberikan pada pelayanan terkait preventif, paliatif, kuratif dan rehabilitatif

BAB IV

TRIASE

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit berkewajiban memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya di instalasi gawat darurat meliputi triase dan tindakan penyelamatan nyawa (life saving);
- (2) Pada setiap pasien yang datang ke instalasi gawat darurat harus dilakukan triase berbasis bukti;
- (3) Triase merupakan pemeriksaan awal atau skrining secara cepat terhadap semua pasien yang datang ke instalasi gawat darurat untuk mengidentifikasi status kegawatdaruratannya dan prioritas penanganan;
- (4) Setiap staf yang bertugas mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- (5) Staff menggunakan kriteria berbasis bukti untuk memprioritaskan pasien sesuai dengan kegawatannya;

- (6) Prioritas diberikan kepada pasien dengan kebutuhan mendesak.
- (7) Pasien darurat dinilai dan distabilkan sesuai kapasitas rumah sakit sebelum ditransfer ke ruang rawat atau dirujuk
- (8) Semua kegiatan pelayanan di dokumentasikan dalam rekam medis
- (9) Pasien diberikan informasi se jelas-jelasnya mengenai tindakan triase sesuai dalam pemberian pelayanan

Pasal 5

Regulasi tentang penetapan kriteria masuk dan keluar ICU dibahas dalam pedoman tersendiri.

Pasal 6

Penundaan Pelayanan

- (1) Rumah sakit wajib memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga apabila terjadi penundaan dan kelambatan pelayanan dirawat jalan, instalasi gawat darurat dan di rawat inap sesuai dengan kriteria;
 - a. Tempat tidur penuh
 - b. Tindakan yang tidak tersedia di Rumah Sakit
 - c. Pengalihan DPJP utama kepada DPJP penggantiPasien diberi tahu alasan penundaan dan kelambatan pelayanan yang tersedia sesuai kebutuhan klinis pasien dan dilakukan pencatatan didalam rekam medis.

BAB V

REGISTRASI DAN ADMISI DI RUMAH SAKIT

Pasal 7

Registrasi dan Admisi Pasien

- (1) Semua pasien masuk instalasi gawat darurat dan rawat jalan telah didaftar saat proses admisi dan dilakukan pengkajian yang diperjelas dalam alur penerimaan pasien
- (2) Pada proses admisi pasien rawat inap dilakukan skrining kebutuhan pasien untuk menetapkan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif, pelayanan khusus spesialisik atau pelayanan intensif yang diprioritaskan berdasar atas kondisi pasien;
- (3) Rumah sakit mengidentifikasi hambatan dan menerapkan proses untuk mengurangi hambatan bagi pasien yang dilakukan oleh security dan CSO dalam mendapatkan akses, proses penerimaan dan pelayanan perawatan
- (4) Rumah sakit menerapkan pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap baik secara online atau offline
- (5) Rumah sakit memberikan informasi secara jelas pada proses admisi tentang asuhan yang akan diberikan, hasil asuhan yang diharapkan yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Jalan serta perkiraan

biaya yang harus dibayarkan oleh pasien dan keluarga di tempat pendaftaran pasien

- (6) Pasien diterima bila rumah sakit dapat memberi pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat dan rawat inap sesuai dengan yang dibutuhkan pasien;

BAB IV

KESINAMBUNGAN PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Rumah sakit memiliki proses kesinambungan pelayanan dan integrasi antara profesional pemberi asuhan (PPA)
- (2) Dalam melaksanakan tugas yang termaksud dalam ayat satu (1) diatas PPA dibantu oleh Manajer Pelayanan Pasien (MPP)

Pasal 8

Manajer Pelayanan Pasien

- (1) Ada penunjukkan MPP dengan uraian tugas antara lain dalam konteks menjaga kesinambungan dan koordinasi pelayanan bagi individu pasien melalui komunikasi dan kerjasama dengan PPA dan pimpinan unit serta mencakup :
 - (a) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien;
 - (b) Mengoptimalkan terlaksananya pelayanan berfokus pada pasien;
 - (c) Mengoptimalkan proses reimbursemen;
 - (d) Asesmen untuk manajemen pelayanan pasien;
 - (e) Perencanaan untuk manajemen pelayanan pasien;
 - (f) komunikasi dan koordinasi;
 - (g) edukasi dan advokasi;
 - (h) kendali mutu dan biaya pelayanan pasien;
- (2) Manajer Pelayanan Pasien (MPP)/*Case Manager* bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengaturan alur pasien untuk menghindari penumpukan (*fast trek*) sesuai dengan pedoman
- (3) Proses dan pelaksanaan pemberian asuhan yang dilakukan oleh PPA dan MPP untuk mendukung kesinambungan pelayanan dan koordinasi pelayanan, meliputi:
 - (a) Pelayanan darurat dan penerimaan rawat inap;
 - (b) Pelayanan diagnostik dan tindakan;
 - (c) Pelayanan bedah dan nonbedah;
 - (d) Pelayanan rawat jalan;
 - (e) Organisasi lain atau bentuk pelayanan lainnya;
- (4) Pasien yang mendapat pelayanan MPP, pencatatannya dilakukan dalam Form MPP (Form A dan Form B) selalu diperbaharui untuk menjamin komunikasi dengan PPA; pasien yang mendapatkan pelayanan MPP sesuai dengan kriteria
 - a. DPJP lebih 1
 - b. Penyakit kompleks

- c. Pembiayaan resiko
- (5) Kesenambungan dan koordinasi proses pelayanan didukung dengan menggunakan perangkat pendukung, seperti rencana asuhan PPA, catatan MPP, pedoman, atau perangkat lainnya;
 - (6) Kesenambungan dan koordinasi dapat dibuktikan di semua tingkat/fase asuhan pasien.
 - (7) Pasien diskriminasi untuk kebutuhan pelayanan manajemen pelayanan pasien.

Pasal 9

Pemberian asuhan kepada pasien secara terintegrasi berfokus pada pasien melibatkan pemberdayaan pasien dan keluarga.

Pasal 10

Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP)

- (1) Dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) bertindak sebagai ketua tim asuhan pasien dari PPA (*clinical leader*)
- (2) Rumah sakit menetapkan proses perpindahan tanggungjawab koordinasi asuhan pasien dari satu dokter penanggungjawab pelayanan ke DPJP lain termasuk bila terjadi perubahan DPJP utama
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan ayat satu dan dua dalam pasal ini diatur dalam panduan DPJP
- (4) PPA bekerja sebagai tim interdisiplin dan berkolaborasi dengan tim interprofesional lainnya dibantu dengan antara lain :
 - (a) Panduan praktik klinis (PPK);
 - (b) Panduan asuhan profesional pemberi asuhan lainnya;
 - (c) Alur klinis atau *clinical pathway* terintegrasi;
 - (d) Algoritme;
 - (e) Protokol;
 - (f) Prosedur
 - (g) *Standing order*;
 - (h) Catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) sebagai bukti adanya evaluasi dan pencatatan perkembangan pasien sehari-hari.
- (5) DPJP sebagai ketua tim PPA melakukan evaluasi secara berkala harian untuk memantau terlaksanakannya asuhan secara terintegrasi dan membuat notasi sesuai kebutuhan
- (6) Setiap pasien memiliki dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) yang melakukan asuhan pasien secara terkoordinasi dan terdokumentasi dalam rekam medis pasien.

Pasal 11

Rumah sakit harus menciptakan proses untuk kesinambungan termasuk asuhan gizi terintegrasi.

Pasal 12

Saat diterima sebagai pasien rawat inap pasien dan keluarga mendapat

edukasi dan orientasi tentang ruang rawat inap antara lain :

- (a) Cara mematikan dan menghidupkan AC, TV, lampu, air panas
- (b) Cara membuang sampah,
- (c) Penggunaan toilet,
- (d) Penggunaan nurse call,
- (e) Cara menyimpan makanan penunggu pasien,
- (f) Cara cuci tangan 6 langkah,
- (g) Pelaksanaan identifikasi pasien,
- (h) Tata cara pasien complain/pemberian saran,
- (i) Jam besuk pasien,
- (j) Jadwal visite dokter
- (k) Jadwal makan dan diet pasien,
- (l) Jadwal pemberian obat,
- (m) Penekanan pada *general consent*,
- (n) Mencegah terjadinya pasien jatuh, dan
- (o) Informasi mengenai asuhan
 - Mengenai identifikasi
 - Mengenai inform consent
 - Mengenai gizi
 - Mengenai pelepasan informasi

BAB V

TRANSFER PASIEN INTERNAL DALAM RUMAH SAKIT

Pasal 13

- (1) Transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dilengkapi dengan form transfer pasien;
- (2) Form transfer pasien memuat indikasi pasien masuk dan dirawat di rumah sakit;
- (3) Form transfer pasien harus memuat riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik;
- (4) Form transfer pasien harus memuat diagnosa yang dibuat;
- (5) Form transfer pasien harus memuat prosedur yang harus dilakukan;
- (6) Form transfer pasien harus memuat obat yang diberikan dan tindakan lain yang dilakukan;
- (7) Form transfer pasien harus memuat keadaan pasien pada waktu sesaat sebelum dipindah (transfer);
- (8) Form transfer pasien harus memuat petugas yang menyerahkan pasien dan petugas yang menerima pasien yang disertai dengan tanda-tangan
- (9) Alat transport disesuaikan dengan kondisi pasien (penggunaan kursi roda, brankar, dan oksigen)

BAB VIALUR PENERIMAAN, PEMULANGAN, RUJUKAN DAN
TINDAK LANJUT PASIEN

Pasal 15

- (1) Rumah sakit menetapkan pengelolaan alur pasien secara efektif mulai dari penerimaan, pengkajian, tindakan, transfer pasien, sampai dengan pemulangan antara lain :
 - (1) Alur pendaftaran pasien rawat jalan;
 - (2) Alur pendaftaran pasien rawat inap;
 - (3) Alur pendaftaran pasien gawat darurat;
 - (4) Alur penerimaan pasien gawat darurat ke unit rawat inap;
 - (5) Alur menahan pasien untuk observasi;
 - (6) Alur mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju maupun di seluruh rumah sakit;
 - (7) Alur untuk menghindari penumpukan termasuk pada keadaan bencana;
- (2) Pengelolaan yang efektif terhadap alur pasien (seperti penerimaan, asesmen dan tindakan, transfer pasien, serta pemulangan) dilaksanakan agar dapat mengurangi penundaan asuhan kepada pasien;
- (3) Komponen dan pengelolaan alur pasien sesuai yang dimaksud pada ayat dua (2) di atas meliputi :
 - (a) Ketersediaan tempat tidur sementara atau transit atau intermediet sebelum mendapatkan tempat tidur di rawat inap;
 - (b) Perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien;
 - (c) Perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukan pasien di beberapa lokasi sementara dan atau pasien yang tertahan di unit darurat;
 - (d) Alur pelayanan pasien di tempat sementara atau transit meliputi : pemberian asuhan, tindakan, dan pelayanan (seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca-anestesi harus sama seperti yang diberikan di rawat inap);
 - (e) Efisiensi pelayanan nonklinis penunjang asuhan dan tindakan kepada pasien (seperti kerumahtanggaan dan transportasi);
 - (f) Memberikan asuhan pasien yang sama kepada pasien yang dirawat ditempat sementara/transit seperti peralatan pada pasien yang diberikan di ruang rawat inap
 - (g) Pemberian pelayanan ke rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien;
 - (h) Akses pelayanan yang bersifat mendukung (seperti pekerja sosial, keagamaan atau bantuan spiritual, dan sebagainya).
- (4) Rumah sakit melakukan evaluasi terhadap pengelolaan alur pasien secara berkala dan melaksanakan upaya perbaikan.

Pasal 15

Discharge Planning

- (1) Rumah sakit mengidentifikasi kebutuhan pasien untuk perawatan berkelanjutan pada pasien dengan kriteria;

- a. Penyakit kompleks
 - b. Pembiayaan tinggi
 - c. Rawan komplain
 - d. DPJP lebih dari 1
- (2) Discharge planning tertulis sejak pasien masuk rumah sakit pada saat assesment awal medis yang di lakukan oleh MPP dan PPA yang tertulis dalam Form A dan Form B serta Form Discharge Planning

Pasal 16

Pemulangan Pasien

- (1) Rumah sakit menetapkan kriteria pemulangan pasien sesuai dengan kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien yang dicatat di form pengkajian awal
- (2) Rumah sakit menetapkan ringkasan pasien pulang (*discharge planning*) yang meliputi :
 - (a) Indikasi pasien masuk dirawat, diagnosis, dan komordibitas lain;
 - (b) Temuan fisik dan temuan-temuan lain;
 - (c) Tindakan diagnostik dan prosedur terapi yang telah dikerjakan;
 - (d) Obat yang diberikan selama rawat inap dengan potensi akibat efek residual setelah obat tidak diteruskan dan semua obat yang harus digunakan dirumah
 - (e) Kondisi pasien (status present); dan
 - (f) Instruksi tindak lanjut
- (3) Pelaksanaan asuhan dilakukan secara terintegrasi termasuk perencanaan pemulangan pasien (*discharge planning*)
- (4) Pasien dan keluarga diberikan edukasi tentang rencana pemulangan (*discharge planning*), Pendidikan berkelanjutan yang diperlukan untuk kesinambungan asuhan pasien dirumah.
- (5) Pasien dan keluarga diberikan edukasi tentang intruksi tindak lanjut dan apa yang tertera dalam form ringkasan pasien pulang seperti yang tercantum pada ayat dua (2) pasal ini
- (6) Salinan ringkasan pulang minimal berjumlah empat, diperuntukkan untuk :
 - (a) Salinan ringkasan berada di rekam medis pasien.
 - (b) Satu Salinan/copy dari ringkasan diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertanggungjawab memberikan tindak lanjut asuhan kepada pasien.
 - (c) Satu salinan diberikan kepada pasien atau keluarga sesuai dengan regulasi rumah sakit yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (d) Satu salinan diberikan kepada penjamin.

Pasal 17

Rujukan

- (1) Rumah sakit memiliki regulasi mengenai rujukan sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Apabila rumah sakit tidak bisa memenuhi kebutuhan pasien sesuai misi

dan sumber daya yang ada, maka rumah sakit akan merujuk pasien ke fasilitas pelayanan sesuai kebutuhan;

- (3) Rumah sakit memiliki kerjasama dengan rumah sakit yang menerima rujukan yang sering dirujuk
- (4) Rujukan dilaksanakan atas persetujuan pasien atau keluarga;
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
- (6) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya form rujukan meliputi :
 - (a) diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - (b) alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - (c) risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - (d) transportasi rujukan;
 - (e) risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- (7) Terdapat staf yang bertanggungjawab dan kompeten dalam pengelolaan rujukan untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien.

Pasal 18

Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan rujukan adalah :

- (1) Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan rumah sakit untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- (2) Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat;
- (3) Membuat surat pengantar rujukan yang disampaikan kepada penerima rujukan.

Pasal 19

Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 sekurang-kurangnya memuat :

- (a) Identitas pasien;
- (b) Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
- (c) Diagnosis kerja
- (d) Kebutuhan pelayanan;
- (e) Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
- (f) Tujuan rujukan;
- (g) Kategori pendamping pasien transfer
- (h) Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dan disertai stempel rumah sakit yang dituju.

Pasal 20

- (1) Pasien atau keluarga diberi penjelasan apabila rujukan yang dibutuhkan tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Bukti tentang penjelasan kepada pasien dan keluarga apabila rujukan yang dibutuhkan tidak dapat dilaksanakan dengan wawancara staff terkait dan pasien / keluarga.

Pasal 21

Meninggalkan Rumah Sakit Tanpa Pemberitahuan

- (1) Rumah sakit menetapkan aturan tentang pasien rawat inap dan rawat jalan yang meninggalkan rumah sakit tanpa pemberitahuan (melarikan diri)
- (2) Pasien yang tersebut dalam ayat satu diatas dicatat dalam rekam medis dan dilakukan identifikasi pasien yang cenderung membahayakan dirinya :
 - (a) Pasien mau bunuh diri atau membahayakan dirinya sendiri,
 - (b) Penyakit menular,
 - (c) Pasien yang agresif, dan
 - (d) Membahayakan lingkungan
- (3) Jika terdapat pasien yang tersebut dalam ayat satu maka rumah sakit wajib memberikan laporan kepada pihak yang berwenang :
 - (a) Penyakit menular kepada dinas kesehatan atau kementerian kesehatan
 - (b) Memberikan informasi pasien yang mencelakakan dirinya atau orang lain kepada keluarganya
 - (c) Kekerasan atau kriminal kepada kepolisian

Pasal 22

Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ)

- (1) Rumah Sakit menetapkan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) pada pasien rawat jalan yang membutuhkan asuhan yang kompleks atau diagnosa yang kompleks yang dibuat dalam catatan tersendiri.
- (2) Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) memuat informasi meliputi;
 - (a) Identifikasi pasien yang menerima asuhan kompleks atau dengan diagnosa kompleks
 - (b) Identifikasi informasi yang dibutuhkan oleh para dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) yang menangani pasien
 - (c) Proses yang digunakan untuk memastikan bahwa informasi medis yang dibutuhkan dokter penanggungjawab pelayanan tersedia dalam format mudah ditelusur (*easy-to-retrieve*) dan mudah di-review
 - (d) Evaluasi hasil implementasi proses untuk mengkaji bahwaq informasi dan proses memenuhi kebutuhan dokter penanggungjawab
- (3) Form yang tersedia dalam penulisan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) mudah di telusur dan mudah di review serta di implementasikan

BAB VII

TRANSPORTASI

Pasal 23

- (1) Kebutuhan transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien yang meliputi :
 - (a) Pengkajian kebutuhan transportasi
 - (b) SDM
 - (c) Obat
 - (d) Bahan medis habis pakai
 - (e) Alat kesehatan
 - (f) Peralatan medis
 - (g) Persyaratan PPI yang sesuai dengan kebutuhan pasien
- (2) Kendaraan transportasi untuk merujuk, memindahkan atau memulangkan pasien dipelihara secara rutin sesuai dengan standart pemeliharaan terkait jenis kendaraan yang digunakan.
- (3) Bila Rumah sakit bekerja sama dengan jasa transportasi terdapat bukti kerja sama tersebut dan evaluasi berkala dari Rumah Sakit mengenai kelayakan kendaraan transportasi yang memenuhi aspek mutu keselamatan pasien dan keselamatan transportasi
- (4) Selama proses transportasi rujukan, pemindahan dan pemulangan pasien terdapat staff yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;
- (5) Alat transportasi yang digunakan tersebut dalam ayat empat (4) harus sesuai dengan program PPI, mutu dan keselamatan pasien

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien sebagaimana dimaksud Pasal 1 sampai 24 tercantum dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR: 319.33/I-PND/IGD/IV/2025
TENTANG PANDUAN AKSES
KESINAMBUNGAN PELAYANAN RUMAH
SAKIT

PANDUAN AKSES KESINAMBUNGAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah Sakit merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan yang terintegrasi dengan para profesional pember asuhan (PPA) dang tingkat pelayanan yang akan membangun suatu kesinambungan pelayanan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Maksud disusunnya Panduan Akses Kesinambungan Pelayanan Rumah Sakit adalah sebagai panduan dan acuan dalam memberikan system pelayanan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

1.2.2 Tujuan Umum

Menyelaraskan kebutuhan asuhan pasien dengan pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit, mengkoordinasikan pelayanan, merencanakan pemulangan dan tindakan selanjutnya.

1.2.3 Tujuan Khusus

- a. Skrining pasien di Rumah Sakit
- b. Registrasi dan admisi di Rumah Sakit
- c. Pelayanan berkesinambungan
- d. Transfer pasien internal dalam Rumah Sakit
- e. Pemulangan, rujukan dan tindak lanjut
- f. Transportasi atau ambulance

1.3 PENGERTIAN

Suatu proses penerimaan pasien yang terdiri dari gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap dengan mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien sesuai misi dan sumber daya Rumah Sakit. Apabila Rumah Sakit memiliki kemampuan pelayanan dan sumber daya yang dibutuhkan serta konsisten dengan misi dan kemampuan pelayanan maka dipertimbangkan untuk menerima pasien gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap.

SKRINING DALAM AKSES KESINAMBUNGAN PELAYANAN

2.1 Skrining Pasien di Rumah Sakit

A. Definisi

Rumah sakit menetapkan tentang penerimaan pasien dirawat inap atau pemeriksaan pasien dirawat jalan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang telah diidentifikasi sesuai dengan misi serta sumber daya rumah sakit yang ada menyesuaikan kebutuhan pasien dengan misi dan sumber daya rumah sakit bergantung pada informasi yang didapat tentang kebutuhan pasien dan kondisinya lewat skrining pada kontak pertama.

Skrining merupakan pengenalan dini secara pro-aktif untuk menemukan adanya masalah atau faktor risiko. Sehingga skrining bisa dikatakan sebagai usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan yang secara klinis belum jelas, dengan menggunakan tes, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat untuk membedakan orang yang terlihat sehat, atau benar-benar sehat tapi sesungguhnya menderita kelainan ataupun gangguan kesehatan. Skrining pada pasien dapat dilaksanakan melalui kriteria *triage*, *anamnesis* (wawancara riwayat penyakit), evaluasi visual atau pengamatan, pemeriksaan fisik maupun psikologik, laboratorium klinik, ataupun radiologi diagnostik.

Skrining pasien merupakan suatu rangkaian kegiatan melakukan penilaian awal kegawatdaruratan pada setiap pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat. Dalam hal ini skrining pasien dilakukan pada awal di triage primer yang juga meliputi cara mendiagnosis serta memilah penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia.

Skrining dapat terjadi di tempat pasien, ambulans, atau waktu pasien tiba di rumah sakit. Keputusan untuk mengobati, mengirim, atau merujuk dibuat setelah ada evaluasi hasil skrining. Bila rumah sakit mempunyai kemampuan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan serta konsisten dengan misi dan kemampuan pelayanannya maka dipertimbangkan untuk menerima pasien rawat inap atau pasien rawat jalan.

Kegiatan skrining sangat diperlukan dalam pelayanan gawat darurat karena Instalasi Gawat Darurat sebagai pusat pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan gawat darurat selama 24 jam berfungsi untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas dari penyakit dengan pengobatan dini yang sesuai terhadap kasus-kasus kegawatdaruratan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah skrining pasien yang baik sehingga pelayanan kesehatan untuk kasus-kasus gawat dan darurat dapat diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

B. Istilah Dalam Kegiatan Skrining

Beberapa istilah yang perlu diperhatikan dalam kegiatan skrining pasien awal di triase primer, antara lain:

- 1) Triase
Pengelompokan pasien berdasarkan atas berat ringannya trauma/ penyakit serta kecepatan penanganan/pemindahannya.
- 2) Prioritas
Penentuan mana yang harus didahulukan mengenai penanganan dan pemindahan yang mengacu tingkat ancaman jiwa yang timbul.
- 3) Survei primer
Deteksi cepat dan koreksi segera terhadap kondisi yang mengancam jiwa.
- 4) Survei sekunder
Melengkapi survei primer dengan mencari perubahan-perubahan anatomi yang akan berkembang sehingga mungkin akan dapat menjadi semakin parah dan memperberat perubahan fungsi vital yang ada dan berakhir dengan mengancam jiwa bila tidak segera diatasi.
- 5) Pasien gawat darurat
Pasien yang tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan

terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya.

- 6) Pasien gawat tidak darurat
Pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat (misalnya kanker stadium lanjut).
- 7) Pasien darurat tidak gawat
Pasien akibat musibah yang datang tiba-tiba tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya (misalnya luka sayat dangkal).
- 8) Pasien tidak gawat tidak darurat
Pasien yang tidak memerlukan pertolongan segera (misalnya pasien dengan ulcuspustulosum, TBC kulit, dan sebagainya)
- 9) Kecelakaan (*accident*)
Suatu kejadian di mana terjadi interaksi berbagai faktor yang datang secara mendadak, tidak dikehendaki sehingga dapat menimbulkan cedera fisik, mental, ataupun sosial.
Kecelakaan dapat diklasifikasikan menurut kriteria sebagai berikut :
 - a) Mekanisme kejadian
Tertumbuk, jatuh, terpotong, tercekik, tersengat, terbakar (baik karena efek kimia, fisik, listrik, atau maupun radiasi)
 - b) Tempat kejadian
 - (1) Kecelakaan lalu lintas
 - (2) Kecelakaan di lingkungan rumah tangga
 - (3) Kecelakaan di lingkungan pekerjaan
 - (4) Kecelakaan di sekolah
 - (5) Kecelakaan di tempat-tempat umum lain (misalnya di tempat rekreasi, perbelanjaan, area olahraga, dan sebagainya)
 - c) Waktu kejadian
 - (1) Waktu perjalanan (travelling/transport time).
 - (2) Waktu bekerja, sekolah, bermain, dan sebagainya.
- 10) Bencana
Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional yang memerlukan pertolongan dan bantuan.

C. Kriteria Skrining

Adapun kriteria skrining adalah sebagai berikut,

- 1) Skrining Kasus di Dalam dan Luar Rumah Sakit
Petugas Instalasi Gawat Darurat harus dapat menyeleksi pasien sesuai dengan kondisi kegawatdaruratannya sebagai prioritas pertama pelayanan kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang ada untuk pelayanan pasien gawat darurat yang berlaku dan tidak berdasarkan urutan kedatangan pasien untuk kemudian memilah pasien berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia.

Ruang lingkup pelayanan pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat berdasarkan kondisi kegawatdaruratannya meliputi :

- a) Pasien dengan kasus *emergency*, yaitu pasien yang berada dalam kondisi sebagai berikut :
 - (1) Pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat darurat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan bisa menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan yang tepat secepatnya
 - (2) Pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat
 - (3) Pasien akibat musibah/kejadian yang tiba-tiba terjadi, tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya
- b) Pasien dengan kasus *false emergency*, yaitu pasien yang tidak memerlukan pertolongan segera. Dalam kegiatan skrining pasien awal di triage primer, perlu dipahami bahwa kematian dapat terjadi bila seseorang mengalami kerusakan atau kegagalan dari salah satu sistem atau organ di bawah ini, yaitu :
 - (1) Susunan saraf pusat
 - (2) Pernafasan

- (3) Kardiovaskuler
- (4) Hati
- (5) Ginjal
- (6) Pankreas

Kegagalan dari salah satu sistem atau organ tersebut dapat disebabkan oleh :

- (1) Trauma/cedera
- (2) Infeksi
- (3) Keracunan
- (4) Degenerasi (*failure*)
- (5) Asfiksia
- (6) Kehilangan cairan dan elektrolit dalam jumlah yang besar (*excessive loss of water and electrolit*)
- (7) Lain-lain

Pada kasus tertentu di mana penyakit yang diderita tidak termasuk di dalam daftar tersebut di atas, penentuan kasus gawat atau tidak gawat ditentukan oleh dokter yang menangani pasien.

Kegagalan sistem susunan saraf pusat, kardiovaskuler, pernafasan, dan hipoglikemia dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Sedangkan kegagalan sistem organ yang lain dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang relatif lebih lama.

Dengan demikian keberhasilan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) dalam mencegah kematian dan cacat ditentukan oleh:

- (1) Kecepatan menemukan penderita gawat darurat
- (2) Kecepatan meminta pertolongan
- (3) Kecepatan dan kualitas pertolongan yang diberikan:
 - (a) Di tempat kejadian
 - (b) Dalam perjalanan ke rumah sakit
 - (c) Pertolongan selanjutnya secara mantap di rumah sakit
- 2) Proses penerimaan skrining dari luar rumah sakit selain rujukan
Skrining dari luar rumah sakit adalah penerapan upaya mendeteksi terhadap pasien dengan tujuan untuk menentukan kebutuhan pasien sesuai dengan kondisinya.

Tujuan : menentukan kebutuhan pasien sesuai dengan misi dan sumber daya rumah sakit

Prosedur :

- a) Telepon layanan emergency 0341-458679 dan call center 458679 extension 1 (layanan emergency)
- b) Telepon masuk dari CSO ke IGD atau telfon masuk ke igd di terima oleh perawat atau dokter jaga IGD
- c) Tanyakan kondisi, kesadaran, tanda-tanda vital, pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan dan riwayat penyakit sebelumnya
- d) Tanyakan no.telp yg bisa di hub dan alamat lengkap pasien
- e) Menghubungi ruang sesuai dengan kebutuhan pasien oleh dokter / perawat IGD apabila pasien membutuhkan rawat inap
- f) Menghubungi lagi penelpon oleh perawat / dokter IGD
- g) Mengkondisikan perawat pendamping pasien, ketersediaan obat-obatan dan transportasi ambulan untuk menjemput pasien
- 3) Skrining Pasien dengan Keterbatasan Fisik
Macam-macam kecacatan atau keterbatasan fisik pada manusia sebagai berikut,
 - a) Buta (Tuna Netra)
Pasien buta adalah pasien yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Pasien yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda

yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan parsial yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter.

- b) Tuli (Tuna Rungu)
Pasien tuli adalah Pasien yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana Pasien normal pada umumnya. Pasien yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa kembali mendengar dengan baik.
- c) Bisu (Tuna Wicara)
Pasien bisu adalah Pasien yang tidak bisa berbicara dengan Pasien lain. Pasien yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Pasien bisa juga mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.
- d) Cacat Fisik (Tuna Daksa)
Pasien yang tuna daksa adalah Pasien yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya. Contoh yang paling mudah dari tuna daksa adalah orang yang tangannya buntung, kakinya buntung, lumpuh, kakinya kecil sebelah, dan lain sebagainya.
- e) Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita)
Pasien yang tuna grahita adalah Pasien yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental

terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

- f) Cacat Pengendalian Diri (Tuna Laras)
Pasien yang tuna laras adalah Pasien yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu Pasien yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.
- g) Cacat Kombinasi (Tuna Ganda)
Pasien yang tuna ganda adalah Pasien yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti Pasien yang mengalami tangan buntung sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau Pasien yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain-lain.

- Skrining Wilayah
Berikut daftar penyakit yang tidak mampu dilayani / dirawat di RS Prima Husada :

Tabel 1. Jenis Penyakit

JENIS PENYAKIT	INDIKASI	PEMERIKSAAN PENUNJANG
AIDS	Ruang isolasi dan ARV	Rapid test
Thalassemia	Pro transplantasi sumsum tulang belakang	Hapusan darah tepi
COB/COS	Pro trepanasi	CT Scan
Penyakit Jantung Bawaan	Pro operasi	
STEMI	Pro revaskularisasi	CKMB Troponin
Kanker	Pro kemoterapi	CA 125
Fraktur thoraco lumbal	Pro operasi	Radiologi
CKD	Pro HD	BUN Ureum Creatinin

Gangguan Jiwa dengan Gaduh Gelisah	Pro ruang perawatan pasien Jiwa	
---------------------------------------	---------------------------------------	--



(EtiketPasien)

FORMULIR KOMUNIKASI RUMAH SAKIT (PRE RUJUK)

Penerimaan Rujukan			
Waktu Terima Komunikasi	Hari Tanggal Jam		
Nama RS/ PKM			
Nama Penelpon		Jabatan Penelpon	Telp :
Penerima Telepon			
Data Pasien			
Nama Pasien	L/P		Usia : th
Alamat			Pekerjaan :
Keluhan Pasien			
Diagnosis			
Pemeriksaan Fisik			
Keadaan Umum	☐ Baik ☐ Cukup ☐ Kurang ☐ Sesak		GCS
TTV	TD : mmHg, S : °C, N : x/mnt, RR..... x/mnt		
	SpO2 :		Perdarahan
	Hamil ☐ Tidak ☐ Ya, G..... P..... A.....		Uk.
Temuan positif/khusus yang penting			
Hasil penunjang	☐ ECG ☐ Lab ☐ Rad ☐		
Kebutuhan pelayanan	☐ RI/isolasi Bersalin ☐ Operasi/ODC ☐ ICU ☐ Kamar		
Status Penjaminan	☐ Umum (M/TM) ☐ BPJS Kelas (A/BM) ☐ JKK ☐ Asuransi ☐ Perusahaan ☐		
Alasan dirujuk			
Keputusan			
Balasan Rujukan			
Waktu balasan rujukan	: Hari Tanggal Jam		
Penelepon	:	Penerima :	
Ketersediaan sarana prasarana	: ☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia,		
Pertimbangan medis kondisi px	Kebutuhan transfer pasien		
Estimasi kedatangan pasien			
Pasuruan,			
Perujuk		Penerima rujukan	
(.....)		(.....)	

BAB III

TRIASE

3.1 Triase

A. Definisi

Pasien darurat, sangat mendesak, atau pasien yang membutuhkan pertolongan segera diidentifikasi menggunakan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan kebutuhan pasien yang mendesak dengan mendahulukan dari pasien yang lain. Pada kondisi bencana dapat menggunakan triase bencana. Sesudah dinyatakan pasien darurat, mendesak, dan membutuhkan pertolongan segera maka dilakukan asesmen dan menerima pelayanan secepat-cepatnya. Kriteria psikologis dibutuhkan dalam proses triase. Pelatihan bagi staf diadakan agar staf mampu memutuskan pasien yang membutuhkan pertolongan segera dan pelayanan yang dibutuhkan.

Pada waktu skrining dan pasien diputuskan diterima untuk rawat inap, proses asesmen membantu staf mengetahui prioritas kebutuhan pasien untuk pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif, dan dapat menentukan pelayanan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan pasien. Pelayanan preventif (dalam proses admisi) adalah untuk mencegah perburukan/ komplikasi, misalnya antara lain kasus luka tusuk dalam diberikan ATS dan kasus luka bakar derajat berat dimasukkan ke unit luka bakar.

Jika rumah sakit tidak mampu memenuhi kebutuhan pasien dengan kondisi darurat, pasien dirujuk ke rumah sakit lain yang fasilitas pelayanannya dapat memenuhi kebutuhan pasien. Sebelum ditransfer atau dirujuk pasien harus dalam keadaan stabil dan dilengkapi dengan dokumen pencatatan.

Sebagai prioritas pertama pelayanan kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang ada untuk pelayanan pasien gawat darurat yang berlaku dan tidak berdasarkan urutan kedatangan pasien.

B. Kategori Triase Australian Triage Scale (ATS)

Pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat diseleksi berdasarkan kondisi kegawatdaruratannya dengan menggunakan Australian Triage Scale (ATS) sebagai berikut :

- 1) ATS 1 adalah kondisi yang mengancam jiwa (atau resiko besar mengalami kemunduran) dan perlu intervensi yang cepat dan agresif.
- 2) ATS 2 adalah :
 - a) Pasien dengan kondisi yang cukup serius atau mengalami kemerosotan secepat yang apabila tidak ditangani dalam 10 menit dapat mengancam jiwa atau mengakibatkan kegagalan organ.
 - b) Pasien yang dengan pemberian obat yang dimana hasil akhirnya sangat tergantung dari seberapa cepat obat itu diterima oleh pasien (misalnya : trombolisis, antiracun)
- 3) ATS 3 adalah pasien yang datang dengan kondisi yang mungkin akan berkembang menjadi mengancam nyawa atau menimbulkan kecacatan bila tidak ditangani dalam waktu 30 menit
- 4) ATS 4 adalah pasien dengan kondisi yang dapat mengalami kemerosotan atau akan menghasilkan outcome yang berbeda bila dalam 1 jam pasien belum ditangani. Gejala berkepanjangan.
- 5) ATS 5 adalah kondisi pasien yang sudah kronis dengan gejala yang minor, dimana hasil akhirnya tidak akan berbeda bila penanganan ditunda sampai 2 jam setelah kedatangan.

Adapun berikut ini adalah berbagai kondisi yang dapat dikategorikan termasuk sebagai kasus *emergency*, antara lain :

- 1) ATS 1 (Segera)
 - a) Henti Jantung
 - b) Henti Napas

- c) Resiko sumbatan jalan napas
 - d) Frekuensi pernapasan (RR) < 10x/menit
 - e) *Distress* / Kesukaran pernapasan yang sangat berat (*extreme*)
 - f) Tekanan darah < 80 (dewasa) atau syok pada anak/bayi
 - g) Tidak respon atau hanya respon nyeri (GCS < 9)
 - h) Kejang terus menerus atau berkepanjangan
 - i) Overdosis IV dan tidak responsif atau hipoventilasi
 - j) Gangguan perilaku berat dengan ancaman segera terhadap kekerasan yang berbahaya
- 2) ATS 2 (10 menit)
- a) Resiko Jalan Napas – Stridor berat atau produksi air liur berlebih yang membahayakan
 - b) *Distress*/ kesukaran pernapasan berat
 - c) Gangguan Sirkulasi :
 - (1) Kulit berkeringat atau berubah warna karena perfusi yang buruk Detak jantung < 50 atau > 150 (dewasa)
 - (2) Hipotensi dengan gangguan hemodinamik Kehilangan darah hebat
 - (3) Nyeri dada kardiak
 - d) Nyeri sangat hebat – apapun penyebabnya
 - e) Kadar Gula Darah < 2 mmol/l
 - f) Mengantuk, penurunan respon (GCS < 13)
 - g) Hemiparesis / disfasia akut
 - h) Demam dengan tanda-tanda letargi (semua umur)
 - i) Terkena zat asam atau basa pada mata – membutuhkan irigasi
 - j) Multitrauma mayor (membutuhkan respon cepat dari tim terorganisasi)
 - k) Trauma lokal berat – Fraktur mayor, amputasi
 - l) Riwayat penyakit resiko tinggi
 - m) Konsumsi obat penenang atau zat toksik lainnya secara signifikan
 - n) *Envenomation* (tergigit hewan beracun) yang signifikan / berbahaya
 - o) Nyeri hebat yang memberi kesan adanya Pre eklampsia, AAA (*Abdominal Aortic Aneurysm*) / Aneurisma Aorta Abdominalis, atau Kehamilan ektopik
 - p) Perilaku / Psikiatrik :
 - (1) Kasar atau agresif
 - (2) Ancaman langsung terhadap diri sendiri atau orang lain
 - (3) Membutuhkan pengekangan
 - (4) Agitasi atau agresi berat
- 3) ATS 3 (30 menit)
- a) Hipertensi berat
 - b) Kehilangan cukup banyak darah – apapun penyebabnya
 - c) Sesak napas sedang
 - d) Saturasi O₂ 90 – 95
 - e) Kadar Gula Darah > 16 mmol/l
 - f) Riwayat kejang (saat ini sadar)
 - g) Semua demam pada pasien immunosupresi misalnya pasien onkologi, Rx steroid
 - h) Muntah terus menerus
 - i) Dehidrasi
 - j) Cedera kepala dengan kehilangan kesadaran yang singkat – saat ini sadar
 - k) Nyeri sedang sampai berat – apapun penyebabnya, yang membutuhkan analgesik
 - l) Nyeri dada non-kardiak dengan tingkat keparahan sedang
 - m) Nyeri perut tanpa ciri-ciri resiko tinggi – tingkat keparahan sedang atau pasien usia 65 tahun
 - n) Trauma ekstremitas sedang – deformitas, laserasi yang parah,
 - o) Ekstremitas – Perubahan sensasi, tidak ada pulsasi
 - p) Trauma – Riwayat penyakit resiko tinggi tanpa resiko tinggi lainnya
 - q) Neonatus stabil
 - r) Anak beresiko

- s) Perilaku / Psikiatrik :
 1. Sangat tertekan, resiko menyakiti diri sendiri
 2. Psikotik akut atau gangguan pikiran
 3. Krisis situasional, sengaja menyakiti diri sendiri
 4. Agitasi / menarik diri / berpotensi agresif
- 4) ATS 4 (60 menit)
 - a) Perdarahan ringan
 - b) Aspirasi benda asing, tanpa distress pernapasan
 - c) Cedera dada tanpa nyeri pada tulang iga atau distress pernapasan
 - d) Kesulitan menelan, tanpa distress pernapasan
 - e) Cedera kepala ringan, tidak kehilangan kesadaran
 - f) Nyeri sedang, dengan beberapa faktor resiko
 - g) Muntah atau diare tanpa dehidrasi
 - h) Inflamasi atau benda asing pada mata – penglihatan normal
 - i) Trauma ekstremitas minor – pergelangan kaki terkilir, kemungkinan patah tulang, laserasi tidak terkomplikasi yang membutuhkan investigasi atau intervensi – tanda vital normal, nyeri ringan / sedang
 - j) Gips terlalu ketat, tanpa kerusakan neurovaskuler
 - k) Sendi bengkak dan panas
 - l) Nyeri perut tidak spesifik
 - m) Perilaku / Psikiatrik :
 1. Masalah kesehatan mental semi-urgent
 2. Dalam observasi dan/atau tidak ada resiko langsung terhadap diri sendiri maupun orang lain
- 5) ATS 5 (120 menit)
 - a) Nyeri minimal tanpa ciri-ciri beresiko tinggi
 - b) Riwayat penyakit resiko rendah dan saat ini asimtomatik
 - c) Gejala minor dari penyakit stabil yang ada
 - d) Gejala minor dari kondisi dengan resiko rendah
 - e) Luka minor – lecet kecil, laserasi ringan (tidak membutuhkan jahitan)
 - f) Dijadwalkan kontrol misalnya pada kontrol luka, perban kompleks
 - g) Imunisasi
 - h) Perilaku / Psikiatrik :
 1. Pasien yang dikenal dengan gejala kronis
 2. Krisis sosial, pasien baik secara klinis

Untuk pasien anak-anak digunakan standar yang berbeda, karena kondisi pada anak jauh lebih berbahaya dari pada dewasa.

	RISIKO TINGGI	RISIKO SEDANG
Pemberian makanan	< ½ normal	1/2 - 2/3 normal
Arousal / Tingkat kewaspadaan (SSP)	Sering mengantuk Penurunan aktivitas Konvulsi Tangisan lemah	Kadang mengantuk
Pernapasan	Apnea atau Sianosis	Sesak napas
Sirkulasi	Kulit pucat dan panas	Kulit pucat
Output cairan	Muntah kehijauan < 4 x popok basah / hari	>5 x muntah dalam 24 jam Kencing kurang dari biasanya
Feses	Tinja berdarah	

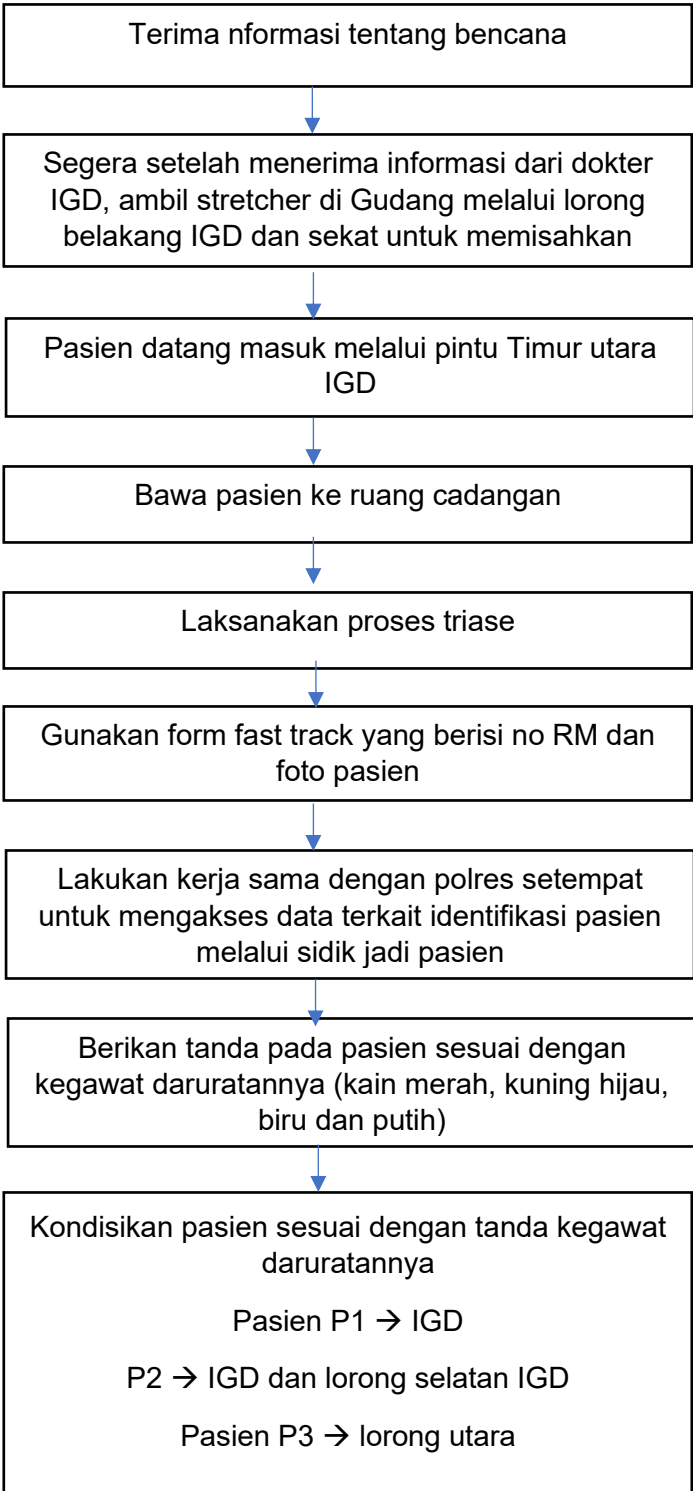
Kategori	Waktu respon maximum
ATS 1	Segera
AT S 2	10 menit
ATS 3	30 menit
ATS 4	60 menit
ATS 5	120 menit

Alur Triage Bencana

Pasien diterima di IGD dan dilakukan skrining dengan :

1. No. RM X 1
No. RM X 2 dst
2. No. RM kelompok perusahaan / instansi / group
3. Kerjasama / koordinasi dengan Dukcapil
4. Foto Muka ditempel di RM
5. Kerjasama / koordinasi dengan pihak kepolisian dengan mencocokkan data Sim dan sidik jari

ALUR FAST TRACK



Apabila terjadi penumpukan pasien karena kondisi bencana, maka pasien akan diletakkan :

1. Ruang Observasi / P.3
2. Seputar Nurse Station IGD
3. Halaman IGD
4. Ruang Rapat Lt.2

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis apabila ada bencana akan dibantu oleh :

1. Karyawan dari unit lain yang sekiranya unit tersebut dapat ditinggal
2. Karyawan yang libur
3. Bekerjasama dengan fasilitas Kesehatan setempat untuk mengirimkan tenaga medisnya



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

(Etiket Pasien)

TRIAGE

Tanggal Kunjungan		Pukul..... WIB			
Rujukan ☐ Ya ☐ Tidak		☐ RS :..... ☐ Dokter:..... ☐ Bidan:..... ☐ PKM:..... ☐ Perawat:..... ☐			
Jenis Penyakit		1. Menular ☐ Tidak ☐ Ya 2. <i>Immunocompromised</i> ☐ Tidak ☐ Ya 3. <i>Airbone Disease</i> ☐ Tidak ☐ Ya ☐ Ya(*) Bila salah satu jawaban “ya”, lakukan prinsip PPI			
AIRWAY	BREATHING	CIRCULATION	DISABILITY	EXPOSURE	PRE HOSPITAL
☐ Bebas ☐ Sumbat anparsial ☐ Sumbat antotal	☐ HentiNapas ☐ RR<12x/menit ☐ RR12-20x/menit ☐ RR20-30x/menit ☐ RR>30x/menit ☐ Wheezing ☐ Rhonki : Basah/Kering* ☐ Retraksi	☐ HentiJantung ☐ Nadi tidak teraba ☐ Nadi<60x/menit ☐ Nadi60-100x/menit ☐ Nadi>100x/menit ☐ TD Sistol<90 ☐ TDSistol90-119 ☐ TDSistol120-139 ☐ TDSistol140-159 ☐ TDSistol≥160	GCS E:Eye ☐ 1(Tidak membuka mata) ☐ 2 (Membuka mata dengan rangsang nyeri (dicubit,ditepuk) ☐ 3 (Membukamata dengan rangsang suara (dipanggil) ☐ 4 (Membuka mata secara spontan) V:Verbal ☐ 1(Tidak bersuara) ☐ 2 (Bersuara tidak jelas (mengerang,menggumam) ☐ 3 (Hanya berkata-kata saja (aduh..ah..auw..) ☐ 4 (Berbicara mengacau, bingung) saja ☐ 5 (Orientasi baik) M:Motorik ☐ 1(TidakBergerak) ☐ 2(Esktensi abnormal,deserebasi (tangan ekstensi dan mengepal disisi tubuh, kaki ekstensi saat dirangsang nyeri) ☐ 3(Fleksia bnormal, dekortikasi (tanganfleksi diatas dada dan kaki ekstensi saat dirangsang nyeri) ☐ 4 (Fleksinormal (menarik anggota tubuh yang dirangsang nyeri) ☐ 5(Melokalisir nyeri (menjangkau lokasi dan menjauhkan stimulus) ☐ 6 (Mematuhi perintah)	☐ Perdarahan ☐ Fraktur ☐ Parese ☐ Plegi ☐ Paraparese	☐ RJP ☐ Intubasi ☐ O2 ☐ Collar ☐ Bidai ☐ Catheter ☐ Infus ☐ NGT ☐

		☐ TDDiastol<80 ☐ TDDiastol80-89 ☐ TDDiastol90-99 ☐ TDDiastol>100	PenilaianGCSDanKesa daran ☐ GCS(15-14)Composmentis ☐ GCS(13-12)Apatis ☐ GCS(11-10)Delirium ☐ GCS(9-7)Somnolen ☐ GCS(6-5)Sopor ☐ GCS(4)Semikoma ☐ GCS(3)Koma				
KATEGORI: ☐ ATS1(Immediate) ☐ ATS2(<10Menit) ☐ ATS3(30Menit) ☐ ATS4(60Menit) ☐ ATS5(120Menit)							
<u>Penempatan sesuai warna kelambu</u>		☐ P0: Pasien Meninggal	☐ P1: Mengancam Nyawa	☐ P2: Emergency	☐ P3: Urgent	☐ P4: Non Urgent	☐ P5: Pasien pulang/ Poli

D. Kriteria Keluar dan Masuk ICU
 Lampiran tentang penetapan kriteria masuk dan keluar dibahas dalam pedoman tersendiri.



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RM 13.2

(Etiket Pasien)

KRITERIA KELUAR – MASUK ICU

MASUK	KELUAR
TanggalPukul.....WIB	TanggalPukul WIB
1) Sistem Cardiovaskuler : ☐ <i>Acute Coronary Syndrome</i> (ACS) : tanpa atau dengankomplikasi dan mungkin disertai penyakit penyerta lainnya ☐ Syok Cardiogenik ☐ Kegawatan irama jantung ☐ Gagal jantung dan paru akut ☐ Kegawatan hipertensi disertai kegawatan kardiovaskuler ☐ Kegawatan penyakit jantung katup ☐ Kegawatan penyakit jantung kongenital ☐ Kegawatan vaskuler (diseksi aorta, emboli paru, sumbatan pembuluh darah vena dalam dan arteriperiver) ☐ Kegawatan kardiovaskuler lainnya (endokarditis,miocarditis, tamponade jantung, trauma jantung) ☐ Pasien kardiovaskuler yang memerlukan pemantauanhemodinamik untuk evaluasi terapi ☐ Serangan asma berat ☐ Status epileptikus ☐ Anemia gravis dengan hemodinamik tidak stabil ☐ Bronkopneumonia dengan hemodinamik tidak stabil ☐ Kelainan jantung kritikal ☐ Gagal jantung pada anak ☐ Kegawatan jantung yang diakibatkan oleh syok hipovolemik yang mengakibatkan hemodinamik tidakstabil	☐ Pasien sudah stabil yang tidak lagi membutuhkan pemantauan yang ketat tentang pernafasan (C,A,B) ☐ Pasien meninggal ☐ Rujuk ☐ Pulang Paksa (APS)
2) SistemPernafasan ☐ Pneumonia, COPD, asma, gagal nafas dengan atau tanpa menggunakan ventilator mekanik	

3) Sistem Syaraf ☐ CVA <i>Bleeding</i> dengan penurunan kesadaran tanpa adanya tindakan <i>trepanasi</i> ☐ CVA <i>Trombosis</i> yang meluas disertai dengan penurunan kesadaran ☐ GBS (Guillain Barre syndrome) dengan gejala sesak nafas dengan atau tanpa penggunaan ventilator mekanik	
4) Kondisi Lain – lain : ☐ ☐ .. ☐ ..	
Berdasarkan kriteria yang sesuai dengan pasien diatas, maka pasien dapat dipindahkan dari Ruangke Ruang Mohon penatalaksanaan yang sesuai dengan kriteria pasien diatas Petugas Pengirim Petugas Penerima ((.....) ...)	Berdasarkan kriteria yang sesuai dengan pasien diatas, maka pasien dapat dipindahkan dari Ruangke Ruang Mohon penatalaksanaan yang sesuai dengan kriteria pasien di atas Petugas Pengirim Petugas Penerima ((.....) .)

E. Penundaan Pelayanan

- 1) Pengertian
- Pasien diberitahu jika ada penundaan dan kelambatan pelayanan antara lain akibat kondisi pasien atau jika pasien harus masuk dalam daftar tunggu. Pasien diberi informasi alasan dan sebab mengapa terjadi penundaan/kelambatan atau harus menunggu serta diberi tahu tentang alternatif yang tersedia, ketentuan ini berlaku bagi pasien rawat inap dan rawat jalan. Untuk beberapa pelayanan, seperti onkologi atau transplan tidak berlaku ketentuan tentang penundaan/kelambatan pelayanan atau tes.

2) Form Penundaan Pelayanan



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

(Etiket Pasien)

PEMBERIAN INFORMASI PENUNDAAN PELAYANAN

DPJP Pelaksana Tindakan		
Pemberi Informasi		
Penerima Informasi /Pemberi Persetujuan*		Sebagai.....
Jenis Informasi	Isi Informasi	√
Jenis penundaan pelayanan	☐ Penundaan dan kelambatan pelayanan akibat kondisi pasien	
	☐ Pasien harus masuk dalam daftar tunggu kamar	

Alasan Penundaan		
Alternatif yang Tersedia		
Lain Lain		
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menjelaskan hal-hal tersebut di atas secara benar dan jelas serta memberikan kesempatan untuk bertanya dan / atau berdiskusi dan pasien memahami. (Pemberi Informasi)	TTD	
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana adanya di atas yang sudah diberi tanda (√) dikolom kanannya dan saya telah memahaminya. (Pemberi Persetujuan)	TTD	
Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat		

BAB IV

REGISTRASI DAN ADMISI PELAYANAN

4.1 Registrasi dan Admisi Pasien

A. Definisi

Admisi merupakan hak atau izin masuk masuk bagi pasien yang berfungsi sebagai koordinator untuk penerimaan pasien d rawat inap, baik yang berasal dari isntalasi gawat darurat (IGD) atau rawat jalan (poliklinik). Admisi memiliki tanggungjawab dalam pendaftaran pra penerimaan pasien, penerimaan pasien dan penentuan ruang perawatan.

Fungsi bagian admisi pelayanan rumah sakit

- 1) Sebagai koordinator untuk penerimaan pasien di rawat inap baik dari IGD atau poliklinik
- 2) Melaksanakan instruksi rujukan dari rawat jalan dan emergency
- 3) Mengatur tujuan pengiriman pasien ke ruang bangsal sesuai dengan instruksi rujukan dan kondisi yang ada
- 4) Menentukan posisi pasien dalam daftar tunggu (waiting list) untuk mendapatkan pelayanan misalnya tindakan pembedahan atau tindakan pemeriksaan radiologi atau laboratorium

B. Jenis bagian admisi

- 1) Satu area
- 2) Admisi terpisah, penerimaan rawat jalan dan rawat inap dalam dua tempat terpisah

C. Petugas admisi memiliki kemmapuan,

- 1) Dapat memberikan penjelasan tentang segala yang menyangkut operasi kegiatan rumah sakit seperti fasilitas, tipe bed yang tersedia, tarif kamar, pemeriksaan yang dapat dilakukan di rumah sakit, serta alternatif yang tersedia lainnya,
- 2) Dapat memberikan pendapat dan altenatif dari banyak pilihan pada pasien, sehingga dengan demikian pasien merasa sangat terbantu
- 3) Dapat mengubah pendapat pasien dari “tidak” menjadi “iya”
- 4) Dapat menilai keinginan dan kebutuhan pasien secaa pasti dan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan pasien

D. Ruang lingkup admisi mencakup;

- 1) Pengaturan jadwal pasien
- 2) Penempatan pasien
- 3) Pendaftaran pendahuluan, pendaftaran pasien rawat jalan, pendaftaran, paktek dokter, ruang perawatan, uang darurat
- 4) Informasi kepada pasien
- 5) Memproses formulir izin perawatan, ijin memberikan informasi perawatan
- 6) Pembuatan sesus haian dan laporan khusus
- 7) Memelihara system identifikasi pasien
- 8) Hungan dengan klien/pasien
- 9) Telekomunikasi
- 10) Transportasi pasien
- 11) Uji diagnostik
- 12) Pemasaran/penghubung dengan praktek dokter
- 13) Bidang lain, seperti manajemen rekening pasien, manajemen sumber daya, kontrak perawatan terpadu, rencana pemulangan pasien dan manajen resiko

E. Proses administrasi admisi pasien meliputi informasi demografis, kuangan/hukum, sosial, admisirasi/klerikal dan klinis

- 1) Data demografis
 - (a) Nama pasien
 - (b) Alamat dan nomor telepon pasien
 - (c) Tanggal lahir
 - (d) Jenis kelamin dan suku
 - (e) Nomor jaminan sosial (kesehatan) bila ada

-
- 2) Data keuangan/hukum
 - (a) Nama penjamin (orang yang bertanggungjawab atas pembiayaan pasien/perusahaan)
 - (b) Nama dan alamat perusahaan asuransi beserta verifikasi keabsahan keanggotaan pasien
 - (c) Perincian jumlah utang yang belum dibayar
 - (d) Penyelesaian formulir asuransi dan informasi lain tentang pembayaran pihak ketiga
 - (e) Tanda tangan pasien tentang persetujuan perawatan dengan ketentuan berlaku
 - 3) Data sosialisasi
 - (a) Orang yang harus dihubungi dalam keadaan darurat meliputi nama, alamat dan nomor telepon
 - (b) Ijin untuk menerima pengunjung
 - (c) Agama
 - (d) Jenis pekerjaan
 - 4) Data administrasi
 - (a) Tanggal dan waktu pendaftaran
 - (b) Siapa yang memberikan dan memasukkan informasi
 - (c) Sumber rujukan, sendiri atau rumah sakit lain
 - (d) Cara datang misalnya dengan ambulans atau jalan kaki, dsb
 - (e) Pilihan kamar dan dokter yang merawat
 - (f) Nomor rekening dan atau nomor rekam medis pasien
 - 5) Data klinis
 - (a) Rincian hasil pemeriksaan pasien
 - (b) Diagnosis
 - (c) Nama dokter, alamat dan no. Tlp.
 - (d) Perintah dokter
 - (e) Rencana perawatan dan pengobatan

ALUR PELAYANAN BPJS RAWAT INAP & RAWAT JALAN RS PRIMA HUSADA

Berdasarkan peraturan Direktur BPJS Kesehatan No. 7581/II.A/0619 Memberikan kemudahan persyaratan pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan .

HANYA DENGAN MEMBAWA  DAN  ANDA SUDAH BISA DILAYANI .

PELAYANAN RAWAT JALAN			RAWAT INAP
Rawat Jalan	Rutin Kontrol	Rawat Inap	UGD
- KTP Asli - Kartu BPJS Asli - Surat Rujukan FKTP - Kartu Asuransi (Jika menggunakan Asuransi)	- Surat Kontrol - KTP Asli - Kartu BPJS Asli - Surat Rujukan FKTP - Rujukan Internal (jika ada)	- Ringkasan Pulang - Kartu Asuransi (Jika menggunakan Asuransi)	- KTP Asli - Kartu BPJS Asli

RESERVASI BY WHATSAPP

PASIENT BPJS / UMUM /ASURANSI

- Foto Surat Kontrol
- Foto Kartu BPJS Kesehatan
- Foto Surat Rujukan FKTP (ONLINE)

KETIK :

1. Jenis Pembayaran ...

2. Nama Lengkap

3. Tempat, Tanggal Lahir :

4. Alamat

5. NIK
6. Poli Tujuan ...

7. Tanggal Kunjungan /Kontrol ..

8. Dokter

Kirim Ke:
0811 349 2244



RESERVASI ONLINE JKN MOBILE



BAB V

KESINAMBUNGAN PELAYANAN

5.1 Proses Kesinambungan Pelayanan dan Integrasi

A. Definisi

Perjalanan pasien di rumah sakit mulai dari admisi, keluar pulang, atau pindah melibatkan berbagai profesional pemberi asuhan (PPA), unit kerja, dan manajer pelayanan pasien (MPP). Selama dalam berbagai tahap pelayanan, kebutuhan pasien dipenuhi dari sumber daya yang tersedia di rumah sakit dan kalau perlu sumber daya dari luar. Kesinambungan pelayanan berjalan baik jika semua pemberi pelayanan mempunyai informasi yang dibutuhkan tentang kondisi kesehatan pasien terkini dan sebelumnya agar dapat dibuat keputusan yang tepat.

Asuhan pasien di rumah sakit diberikan dan dilaksanakan dengan pola pelayanan berfokus pada pasien (Patient Centered Care/ PCC). Pola ini dipayungi oleh konsep WHO.

Pelayanan berfokus pada pasien diterapkan dalam bentuk Asuhan Pasien Terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal. Pada integrasi horizontal kontribusi profesi tiap-tiap profesional pemberi asuhan (PPA) adalah sama pentingnya atau sederajat. Pada integrasi vertikal pelayanan berjenjang oleh/melalui berbagai unit pelayanan ke tingkat pelayanan yang berbeda maka peranan manajer pelayanan pasien (MPP) penting untuk integrasi tersebut dengan komunikasi yang memadai terhadap profesional pemberi asuhan (PPA).

Pelaksanaan asuhan pasien terintegrasi berpusat pada pasien dan mencakup elemen sebagai berikut :

- 1) Keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga
- 2) Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai Ketua tim asuhan pasien oleh profesional pemberi asuhan (PPA)
- 3) Profesional pemberi asuhan (PPA) bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional dibantu antara lain oleh Pedoman Praktik Klinis (PPK), Pedoman Asuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya, Alur Klinis Clinical Pathway terintegrasi, Algoritme, Protokol, Prosedur, Standing Order dan CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi)
- 4) Perencanaan pemulangan pasien (Discharge Planning Terintegrasi)
- 5) Asuhan gizi terintegrasi
- 6) Manajer pelayanan pasien / case manager

Manajer Pelayanan Pasien (MPP) bukan merupakan profesional pemberi asuhan (PPA) aktif dan dalam menjalankan manajemen pelayanan pasien mempunyai peran minimal adalah sebagai berikut :

- 1) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien
- 2) Mengoptimalkan terlaksananya pelayanan berfokus pada pasien
- 3) Mengoptimalkan proses reimbursemen; dan dengan fungsi sebagai berikut :
 - (a) Asesmen untuk manajemen pelayanan pasien;
 - (b) Perencanaan untuk manajemen pelayanan pasien;
 - (c) Komunikasi dan koordinasi;
 - (d) Edukasi dan advokasi;
 - (e) Kendali mutu dan biaya pelayanan pasien.

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan manajemen pelayanan pasien antara lain adalah:

-
- 1) Pasien mendapat asuhan sesuai dengan kebutuhannya
 - 2) Terpelihara kesinambungan pelayanan
 - 3) Pasien memahami/mematuhi asuhan dan peningkatan kemandirian pasien
 - 4) Kemampuan pasien mengambil keputusan
 - 5) Keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga
 - 6) Optimalisasi sistem pendukung pasien
 - 7) Pemulangan yang aman
 - 8) Kualitas hidup dan kepuasan pasien

Agar kesinambungan asuhan pasien tidak terputus, rumah sakit harus menciptakan proses untuk melaksanakan kesinambungan dan koordinasi pelayanan di antara profesional pemberi asuhan (PPA), manajer pelayanan pasien (MPP), pimpinan unit, dan staf lain sesuai dengan rumah sakit di beberapa tempat :

- 1) Pelayanan darurat dan penerimaan rawat inap
- 2) Pelayanan diagnostik dan tindakan
- 3) Pelayanan bedah dan nonbedah
- 4) Pelayanan rawat jalan
- 5) Organisasi lain atau bentuk pelayanan lainnya

Proses koordinasi dan kesinambungan pelayanan dibantu oleh penunjang lain seperti pedoman praktik klinis, alur klinis/clinical pathways, rencana asuhan, format rujukan, daftar tilik/check list lain, dan sebagainya

5.1 Manajer Pelayanan Pasien (MPP)

Untuk melibatkan pasien dalam asuhan yang dialaminya. Bilamana pasien merasa menjadi bagian dalam keputusan pengobatan dan rencana asuhan, maka mereka akan memperoleh manfaat. Hal yang sama juga berlaku bagi keluarganya. Bila keluarga yang mempunyai relasi erat, suatu kemitraan dengan rumah sakit yang melayani orang yang mereka kasihi, mereka akan kurang merasa khawatir tentang logistik dan akan lebih banyak fokus terhadap kesehatan pasien.



Form A – Evaluasi awal MPP (Case Manager)	
Ruangan :	
Tgl, Jam	Catatan
	- Identifikasi / Skrining pasien - Usia lanjut - Kasus penyakit kronis/ terminal katastropik - Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll) - Perkiraan biaya tinggi - Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi) - Pasien dengan fungsi kognitif rendah - Potensial complain tinggi - Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat - Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya - Beresiko membutuhkan kontinuitas pelayanan - Berpotensi masalah hukum - Naik kelas pelayanan ☐ Lain-lain:.....
	- Asesmen untuk manajemen pelayanan pasien - Fisik fungsional : partial/total care - Koqnitif : kooperatif/ tidak kooperatif - Pemahaman tentang Kesehatan : kurang/ cukup/ tidak mampu - Dukungan keluarga : ada/ tidak ada - Perencanaan lanjutan : dirujuk ke komunitas..... - Lain-lain:..... Kepatuhan pasien : ya / tidak
	- Identifikasi masalah – risiko – kesempatan - -
	- Perencanaan manajemen pelayanan pasien - Pendekatan kepada pasien - Jelaskan kepada pasien tentang kondisi dan kemungkinan rencana pelayanan yang akan dilakukan - Lakukan koordinasi dengan PPA untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang penyakit dan segala permasalahannya termasuk rencana pemulangan pasien - Edukasi terhadap keluarga terkait permasalahan pasien - Lain-lain:.....

	• Perencanaan manajemen pelayanan pasien - Pendekatan kepada pasien - Jelaskan kepada pasien tentang kondisi dan kemungkinan rencana pelayanan yang akan dilakukan - Lakukan koordinasi dengan PPA untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang penyakit dan segala permasalahannya termasuk rencana pemulangan pasien - Edukasi terhadap keluarga terkait permasalahan pasien - Lain-lain:.....
--	--

Form B – Catatan Implementasi MPP
--

[illegible]

Catatan	

- Pelaksanaan Rencana manajemen pelayanan pasien
- Monitoring
- Fasilitasi, Koordinasi, Komunikasi dan Kolaborasi
- Advokasi
- Hasil Pelayanan
- Terminasi manajemen pelayanan pasien

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Manajer Pelayanan
Pasien

(.....
.....)

4.1 Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP)

DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) adalah seorang dokter, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit sesuai dengan kewenangna klinis diberikan rumah sakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan dirumah sakit, baik pada pelayanan awal rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya melakukan asesmen medis sampai dengan implementasi rencana serta tindak lanjutnya sesuai kebutuhan pasien.

Penetapan DPJP dilakukan berdasarkan,

- 1) Jadwal konsulan
- 2) Riwayat dokter pasien sebelumnya
- 3) Permintaan pasien atau keluarga



BAB VI

TRANSFER PASIEN INTERNAL DALAM RUMAH SAKIT

5.1 Transfer Unit

A. Definisi

Selama dirawat inap di rumah sakit, pasien mungkin dipindah dari satu pelayanan atau dari satu unit rawat inap ke berbagai unit pelayanan lain atau unit rawat inap lain. Jika profesional pemberi asuhan (PPA) berubah akibat perpindahan ini maka informasi penting terkait asuhan harus mengikuti pasien. Pemberian obat dan tindakan lain dapat berlangsung tanpa halangan dan kondisi pasien dapat dimonitor. Untuk memastikan setiap tim asuhan menerima informasi yang diperlukan maka rekam medis pasien ikut pindah atau ringkasan informasi yang ada di rekam medis disertakan waktu pasien pindah dan menyerahkan kepada tim asuhan yang menerima pasien. Ringkasan memuat sebab pasien masuk dirawat, temuan penting, diagnosis, prosedur atau tindakan, obat yang diberikan, dan keadaan pasien waktu pindah.

B. Formulir Lembar Transfer



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA

(Etiket Pasien)

FORMULIR TRANSFER PASIEN ANTAR UNIT

Transfer Pasien antar unit ☐			
Indikasi di rawat :			
Riwayat Kesehatan:		Pemeriksaan Fisik:	
Pemeriksaan Diagnostik :			
Diagnosis:			
Rencana : ☐ IRNA ☐ Operasi/ ODC ☐ ICU ☐ Kamar Bersalin ☐ R. Isolasi			
Ketersediaan kamar Ada/ Tidak:			
Prosedur / Terapi / Tindakan			
Tindakan	Petugas	Tindakan	Petugas
☐ Pasang infus		☐ Nebul	
☐ Injeksi		☐ Kateter No	
☐ Rawat luka.....		☐ Irigasi mata	
☐ Hecting		☐ NGT	
☐ Tindakan Kegawatan		☐	
Kriteria Transfer		Derajat	Petugas
Pasien stabil membutuhkan ruang perawatan biasa		0	
Pasien delirium atau orang tua		0,5	
Transfer dari atau ke HCU		1	
Saat ini pasien stabil berpotensi tidak stabil			
Pasien tidak stabil, penanganan kegagalan organ/ post operasi besar, membutuhkan observasi ketat		2	
Pasien tidak stabil, Membutuhkan bantuan pernafasan dan atau dengan kegagalan organ		3	
Petugas Yang Menyerahkan		Petugas Yang Menerima	
Waktu Serah Terima	Tanggal..... Pukul WIB	Tanggal..... Pukul WIB	
Keadaan Pasien Waktu Dipindah			
ACC Dokter IGD	☐ Ya ☐ Tidak		
Keadaan Umum	☐ Stabil ☐ Tidak Stabil	☐ Stabil ☐ Tidak Stabil	
TTV	GCS : TD..... mmHg Nadi x/menit RR..... x/menit Tax..... °C SaO2..... lpm	GCS : TD..... mmHg Nadix/menit RRx/menit Tax.....°C SaO2lpm	
Aldrete Score (bila pasien post op)			
Gelang pasien terpasang dan sesuai	☐ Sudah ☐ Belum		
Konsul DPJP	☐ Sudah ☐ Belum		
Risiko Jatuh	☐ Ada ☐ Tidak, Terpasang gelang ☐ Ya ☐ Tidak		
Dokumen Rekam Medis	☐ Datang bersamaan ☐ Terlambat		
Catatan Administrasi			
Petugas yang menyerahkan pasien		Petugas yang menerima pasien	
(.....)		(.....)	

BAB VII

ALUR PENERIMAAN, PEMULANGAN, RUJUKAN DAN TINDAK LANJUT PASIEN

6.1 Alur Pasien

Staf memahami dan mampu melaksanakan proses penerimaan pasien, proses tersebut meliputi :

- a. pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap;
- b. penerimaan langsung dari unit darurat ke unit rawat inap;
- c. menahan pasien untuk observasi.

Dalam rangka keterbukaan kepada publik tersedia sistem pendaftaran rawat inap dan rawat jalan secara online menggunakan billing SIMRS.

Saat diputuskan rawat inap, dokter yang memutuskan rawat inap memberi informasi tentang rencana asuhan yang diberikan, hasil asuhan yang diharapkan, termasuk penjelasan oleh petugas pendaftaran tentang perkiraan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien / keluarga. Pemberian informasi didokumentasikan.

Unit darurat yang penuh sesak dan tingkat hunian rumah sakit yang tinggi dapat menyebabkan pasien menumpuk di daerah unit darurat dan menciptakannya sebagai tempat menunggu sementara pasien rawat inap. Mengelola alur berbagai pasien selama menjalani asuhannya masing-masing menjadi sangat penting untuk mencegah penumpukan yang selanjutnya mengganggu waktu pelayanan dan akhirnya juga berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Pengelolaan yang efektif terhadap alur pasien (seperti penerimaan, asesmen dan tindakan, transfer pasien, serta pemulangan) dapat mengurangi penundaan asuhan kepada pasien.

6.2 Komponen Pengelolaan Alur Pasien

Adapun komponen pengelolaan alur pasien adalah sebagai berikut,

- a. Ketersediaan tempat tidur rawat inap
- b. Bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju pada seluruh rumah sakit pasien di transitkan pada ruangan yg tersedia dengan menyetujui pada form penundaan bersedia menunggu ruangan.
Ruangan yang digunakan :
 - Ruang Maternitas Lt.2 area selatan sebelah tangga
- c. Bila tidak bersedia menunggu ruangan pasien dirujuk.
- d. Perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien;
- e. Perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukan pasien di beberapa lokasi sementara dan atau pasien yang tertahan di unit darurat;
- f. Alur pasien di daerah pasien menerima asuhan, tindakan, dan pelayanan (seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca-anestesi);
- g. Efisiensi pelayanan nonklinis penunjang asuhan dan tindakan kepada pasien (seperti kerumah tanggaan dan transportasi);
- h. Pemberian pelayanan ke rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien;
- i. Akses pelayanan yang bersifat mendukung (seperti pekerja sosial, keagamaan atau bantuan spiritual, dan sebagainya).

Monitoring dan perbaikan proses ini merupakan strategi yang tepat dan bermanfaat untuk mengatasi masalah. Semua staf rumah sakit, mulai dari unit rawat inap, unit darurat, staf medis, keperawatan, administrasi, lingkungan, dan manajemen risiko dapat ikut berperan serta menyelesaikan masalah arus pasien ini. Koordinasi ini dapat dilakukan oleh seorang Manajer Pelayanan Pasien (MPP) / Case Manager

Alur pasien menuju dan penempatannya di unit gawat darurat berpotensi membuat pasien bertumpuk. Ada penempatan pasien di unit gawat darurat yang merupakan jalan keluar.

Sementara mengatasi penumpukan pasien rawat inap rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit harus menetapkan standar waktu berapa lama pasien di unit darurat dan di unit intermediate, kemudian harus ditransfer ke unit rawat inap rumah sakit. Diharapkan rumah sakit dapat mengatur dan menyediakan tempat yang aman bagi pasien.

Unit yang memberikan layanan intensif (misalnya ICU, ICCU, pascaoperasi) atau unit layanan spesialisik (misalnya unit luka bakar atau transplantasi organ) merupakan unit yang mahal dan biasanya menempati ruangan dengan staf yang terbatas. Setiap rumah sakit harus menetapkan kriteria untuk menentukan pasien yang membutuhkan tingkat pelayanan yang tersedia di unit-unit tersebut.

Dengan mempertimbangkan bahwa pelayanan di unit spesialisik menghabiskan banyak sumber daya, rumah sakit mungkin membatasi hanya pasien dengan kondisi medis yang reversibel yang dapat diterima masuk dan pasien kondisi khusus termasuk menjelang akhir kehidupan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar dapat konsisten maka kriteria menggunakan prioritas atau parameter diagnostik dan atau parameter objektif termasuk kriteria berbasis fisiologis.

Mereka yang berasal dari unit-unit gawat darurat, intensif, atau layanan spesialisik berpartisipasi menentukan kriteria. Kriteria dipergunakan untuk menentukan penerimaan langsung di unit, misalnya masuk dari unit darurat.

Kriteria juga digunakan untuk masuk dari unit-unit di dalam atau dari luar rumah sakit, seperti halnya pasien dipindah dari rumah sakit lain. Pasien yang diterima masuk di unit khusus memerlukan asesmen dan evaluasi ulang untuk menentukan apakah kondisi pasien berubah sehingga tidak memerlukan lagi pelayanan spesialisik. Misalnya, jika status fisiologis sudah stabil dan monitoring intensif baik, tindakan lain tidak diperlukan lagi. Atau pun jika kondisi pasien menjadi buruk sampai pada titik pelayanan intensif atau tindakan khusus tidak diperlukan lagi, pasien kemudian dapat dipindah ke unit layanan yang lebih rendah (seperti unit pelayanan medis atau bedah, rumah penampungan, atau unit pelayanan paliatif).

Kriteria untuk memindahkan pasien dari unit khusus ke unit pelayanan lebih rendah harus sama dengan kriteria yang dipakai untuk memindahkan pasien ke unit pelayanan berikutnya. Misalnya, jika keadaan pasien menjadi buruk sehingga pelayanan intensif dianggap tidak dapat menolong lagi maka pasien masuk ke rumah penampungan (hospices) atau ke masuk ke unit pelayanan paliatif dengan menggunakan kriteria.

Apabila rumah sakit melakukan riset atau menyediakan pelayanan spesialisik atau melaksanakan program, penerimaan pasien di program tersebut harus melalui kriteria tertentu atau ketentuan protokol. Mereka yang terlibat dalam riset atau program lain harus terlibat dalam menentukan kriteria atau protokol. Penerimaan ke dalam program tercatat di rekam medis pasien termasuk kriteria atau protokol yang diberlakukan terhadap pasien yang diterima masuk.

6.3 Discharge Planning

A. Pengertian

Memulangkan pasien ke rumah atau keluarga, didasarkan atas kondisi kesehatan pasien dan kebutuhannya untuk memperoleh kesinambungan asuhan. Dapat juga pasien dirujuk atau dikirim ke praktisi kesehatan di luar rumah sakit. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya yang bertanggung jawab atas asuhan pasien menentukan kesiapan pasien keluar rumah sakit berdasar atas kebijakan, kriteria, dan indikasi rujukan yang ditetapkan rumah sakit. Kebutuhan kesinambungan asuhan berarti rujukan ke dokter spesialis, rehabilitasi fisik, atau bahkan kebutuhan upaya preventif di rumah yang dikoordinasikan oleh keluarga pasien.

Diperlukan proses yang terorganisir dengan baik untuk memastikan bahwa kesinambungan asuhan dikelola oleh praktisi kesehatan atau oleh sebuah organisasi di luar rumah sakit. Pasien yang memerlukan perencanaan pemulangan pasien (dischargeplanning) maka rumah sakit mulai merencanakan hal tersebut sedini- dininya yang sebaiknya untuk menjaga kesinambungan asuhan dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua profesional pemberi asuhan (PPA) terkait/relevan serta difasilitasi oleh manajer pelayanan pasien (MPP). Keluarga dilibatkan dalam proses ini sesuai dengan kebutuhan. Rumah sakit dapat menetapkan tentang kemungkinan pasien diizinkan keluar rumah sakit dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan penting

Dibutuhkan perencanaan untuk mengatur tindak lanjut pemulangan pasien ke praktisi kesehatan atau organisasi lain yang dapat memenuhi kebutuhan kesinambungan asuhan pasien. Rumah sakit yang berada di komunitas tempat praktisi kesehatan juga berada di dalamnya membuat kerja sama formal dan informal. Jika pasien berasal dari komunitas/daerah lain maka rumah sakit akan merujuk pasien ke praktisi kesehatan yang berasal dari komunitas tempat pasien tinggal.

Mungkin juga, pasien membutuhkan pelayanan dukungan dan pelayanan kesehatan pada waktu pasien keluar dari rumah sakit (discharge). Misalnya, pasien mungkin membutuhkan bantuan sosial, nutrisi, keuangan, psikologi, atau bantuan lain padawaktu pasien keluar rumah sakit. Proses perencanaan pemulangan pasien (discharge planning) dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua profesional pemberi asuhan (PPA) terkait serta difasilitasi oleh manajer pelayanan pasien (MPP) memuat bentuk bantuan pelayanan yang dibutuhkan dan ketersediaan bantuan yang dimaksud



DISCHARGE PLANNING CHECK LIST

Kelas / Kamar	
Nama Pasien	
Tanggal Lahir	
Tanggal Masuk	
Agama	
Alamat	
DPJP utama	
Dokter rawat bersama	1.
	2.
	3.
Diagnosis	

Discharge Risk Assessment :	
Pasien tinggal di rumah dengan support komunitas terbatas atau tinggal sendiri	
Membutuhkan bantuan untuk manajemen pengobatan	
Polifarmasi (lebih dari 7 macam obat)	
Membutuhkan diet khusus	
Terpasang alat medis (NGT, Kateter Urine, CVC, Colostomy Bag, Drain, ...)	
Luka akut / kronis / decubitus	
Membutuhkan bantuan untuk manajemen oksigen / nebulizer	
Membutuhkan bantuan untuk Activity Daily Living	
Penurunan kognitif	
Riwayat gangguan mental	
Diagnosa pasien CHF, DM, COPD, HIV-AIDS	
Inkontinensia	
Kondisi terminal (end stage disease)	
Riwayat jatuh	
Ketidakpatuhan terhadap rencana medis	
Rawat inap / kunjungan ke IGD berulang	
Penatalaksanaan Discharge Planning Sesuai Discharge Risk Assessment :	
Penatalaksanaan discharge planning sesuai dengan Discharge Risk Assessment	
Memastikan pasien mempunyai care giver	
Melatih pasien / care giver pasien mengenai manajemen pengobatan	
Melatih pasien / care giver pasien mengenai perawatan luka	

Melatih pasien / care giver mengenai perawatan alat medis yang terpasang (NGT) / Kateter urine /CVC / Colostomy bag / Drain / ...	
Menginformasikan pada pasien / care giver tanda - tanda kegawatan pada pasien	
Menginformasikan jadwal kontrol	
Lain – Lain :	

DICHARGE PLANNING					
KEGIATAN			CATATAN		TANDA TANGAN
AKTIVITAS ☐ Jenis aktivitas yang boleh dilakukan ☐ Prosedur ☐ Alat bantu yang dapat digunakan					
☐ Pengobatan (obat - obatan yang sudah diresepkan untuk dilanjutkan di rumah)					
EDUKASI KESEHATAN ☐ Jadwal Kontrol ☐ Pemeriksaan laboratorium lanjutan ☐ Pengertian dan pemahaman akan efek sampingobat ☐ Obat - obatan alternatif ☐ Pencegahan terhadap kekambuhan ☐ Lainnya					
PERAWATAN DI RUMAH ☐ Kenali tanda dan gejala yang perlu dilaporkan ☐ Pengobatan yang dapat dilakukan di rumahsebelum ke rumah sakit					
DIET ☐ Anjuran pola makan ☐ Batasan makanan					
KEBUTUHAN SPIRITUAL DAN PSIKOLOGIS ☐ Konsultasi spiritual ☐ Pengakuan Dosa ☐ Petugas kedukaan ☐ Pengadilan marah ☐ Rekonsiliasi konflik ☐ Kegiatan keagamaan					
RINCIAN PEMULANGAN ☐ Tanggal pemulangan ☐ Pendamping ☐ Transportasi yang digunakan ☐ Keadaan umum saat pemulangan					
DAFTAR OBAT – OBATAN					
NAMA OBAT	INDIKASI		CARA MINUM	WAKTU MINUM	TANDA TANGAN
JADWAL KONTROL DOKTER					
PERJANJIAN & PEMERIKSAAN	TANGGAL	NOMOR			TANDA TANGAN
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)					
Telah dilakukan edukasi tentang DICHARGE PLANNING Rencana Pasien Pulang kepada : ☐ Pasien ☐ Keluarga pasien, nama : Hubungan dengan pasien:			Pasien (.....)	Keluarga (.....)	MPP (.....)

☐ Tidak dapat memberi edukasi kepada pasien atau keluarga Karena		)	
---	--	---	--

6.4 Rujukan

A. Definisi

Pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain didasarkan atas kondisi pasien dan kebutuhan untuk memperoleh asuhan berkesinambungan. Rujukan pasien antara lain untuk memenuhi kebutuhan pasien atau konsultasi spesialisik dan tindakan, serta penunjang diagnostik. Jika pasien dirujuk ke rumah sakit lain, yang merujuk harus memastikan fasilitas kesehatan penerima menyediakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien dan mempunyai kapasitas menerima pasien.

Diperoleh kepastian terlebih dahulu dan kesediaan menerima pasien serta persyaratan rujukan diuraikan dalam kerja sama formal atau dalam bentuk perjanjian. Ketentuan seperti ini dapat memastikan kesinambungan asuhan tercapai dan kebutuhan pasien terpenuhi. Rujukan terjadi juga ke fasilitas kesehatan lain dengan atau tanpa ada perjanjian formal.

Rujukan pasien sesuai dengan kondisi pasien menentukan kualifikasi staf pendamping yang memonitor dan menentukan jenis peralatan medis khusus. Selain itu, harus dipastikan fasilitas pelayanan kesehatan penerima menyediakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien dan mempunyai kapasitas pasien dan jenis teknologi medis.

B. Proses Rujukan

Diperlukan proses konsisten melakukan rujukan pasien untuk memastikan keselamatan pasien. Proses ini menangani :

- 1) Ada staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan termasuk untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien;
- 2) Selama dalam proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;
- 3) Dilakukan identifikasi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan peralatan medis yang dibutuhkan selama proses rujukan;
- 4) Dalam proses pelaksanaan rujukan, ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima.

Rumah sakit melakukan evaluasi terhadap mutu dan keamanan proses rujukan untuk memastikan pasien telah ditransfer dengan staf yang kompeten dan dengan peralatan medis yang tepat. Informasi tentang pasien dirujuk disertakan bersama dengan pasien untuk menjamin kesinambungan asuhan.

C. Form Rujukan

RM13.3



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA

SAHABAT MENUJU

(Etiket Pasien)

FORMULIR RUJUK PASIEN ANTAR RUMAH SAKIT

Identitas Pasien					Tujuan RS Rujukan						
Nama Pasien	:				Kepada:						
No RM	:				Nama Faskes Rujukan	:					
Tanggal Lahir	:				Bagian/ Nama Dokter	:					
Tanggal Masuk	:	Pukul..... WIB			Staf Yang Menerima	:	Bagian:				
Petugas Yang Kontak	:				Telepon	:					
Diagnosis Kerja											
Alasan dirujuk											
Hasil Pemeriksaan											
Keluhan utama											
Riwayat Penyakit											
Riwayat Alergi											
Pemeriksaan Fisik											
Pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan											
Kebutuhan Pelayanan					☐ RI ☐ Isolasi ☐ Operasi ☐ ICU ☐ Kamar bersalin ☐						
Prosedur Dan Intervensi (Terapi Atau Tindakan Yang Telah Dilakukan)											
Tindakan :					☐ Pasang infus ☐ Injeksi ☐ Rawat luka ☐ Hecting ☐ Tindakan kegawatan						
					☐ Nebul ☐ Kateter No ☐ Irigasi mata ☐ NGT ☐						
Terapi											
Dokter Pengirim											
(.....)											
Kategori Pendampingan Pasien Transfer											
Derajat		Petugas Pendamping (Minimal)			Nama Petugas Pendamping						
0		Petugas Ambulan									
0,5 Orang Tua/ Delirium		Petugas Ambulan Dan Paramedis									
1		Petugas Ambulan Dan Perawat									
2		Dokter, Perawat, Petugas Ambulan									
3		Dokter, Perawat, Petugas Ambulan									
Kondisi Pasien											
TD	Nadi	Sebelum Transfer	Setelah Transfer	Saturasi	GCS	TD	Nadi	Sebelum Transfer	Setelah Transfer	Saturasi	GCS
mmHg	x/mnt	x/mnt	C	%		mmHg	x/mnt	x/mnt	C	%	
Catatan:						Catatan:					
Tanggal transferpukul..... WIB						Tanggal tibapukul..... WIB					
Petugas penyerah pasien,						Petugas penerima pasien					
(.....)						(.....)					

6.5 Meninggalkan Rumah Sakit Tanpa Pemberitahuan

A. Pengertian

Rumah sakit menetapkan proses untuk mengelola pasien yang menolak rencana asuhan medis yang melarikan diri. Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan telah selesai menjalani pemeriksaan lengkap dan sudah ada rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan, kemudian pasien ini memutuskan meninggalkan rumah sakit maka pasien ini dianggap sebagai pasien keluar menolak rencana asuhan medis.

Pasien rawat inap dan rawat jalan (termasuk pasien dari unit darurat) berhak menolak tindakan medis dan keluar rumah sakit. Pasien ini menghadapi risiko karena menerima pelayanan atau tindakan tidak lengkap yang berakibat terjadi kerusakan permanen atau kematian. Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan minta untuk keluar dari rumah sakit tanpa persetujuan dokter maka pasien harus diberitahu tentang risiko medis oleh dokter yang membuat rencana asuhan atau tindakan dan proses keluarnya pasien sesuai dengan rumah sakit. Jika pasien mempunyai dokter keluarga maka dokter keluarga tersebut harus diberitahu tentang keputusan pasien. Bila tidak ada dokter keluarga maka pasien dimotivasi untuk mendapat/mencari pelayanan kesehatan lebih lanjut. Harus diupayakan agar mengetahui alasan mengapa pasien keluar menolak rencana asuhan medis. Rumah sakit perlu mengetahui alasan ini agar dapat melakukan komunikasi lebih baik dengan pasien dan atau keluarga pasien dalam rangka memperbaiki proses.

Jika pasien menolak rencana asuhan medis tanpa memberi tahu siapapun di dalam rumah sakit atau ada pasien rawat jalan yang menerima pelayanan kompleks atau pelayanan untuk menyelamatkan jiwa, seperti kemoterapi atau terapi radiasi, tidak kembali ke rumah sakit maka rumah sakit harus berupaya menghubungi pasien untuk memberi tahu tentang potensi risiko bahaya yang ada.

B. Format Pelaporan

Bila pasien masih ada dalam lingkungan rumah sakit, maka segera mengajak kembali pasien dan keluarga pasien tersebut kembali ke ruang perawatan dengan cara yang baik dan sopan. Tetapi bila pasien tidak ditemukan maka perawat segera melapor :

- 1) Ke keamanan secara tertulis pada buku khusus laporan keamanan dengan data pasti tentang pasien meliputi :
 - a. Nama
 - b. Alamat
 - c. Meninggalkan ruangan tanggal : Jam.....
 - d. Ciri-ciri khusus
- 2) Ke Kasir memberikan data perincian biaya pemakaian obat dan alkes, sewa alat, kwitansi dokter, pemeriksaan yang belum diperinci, konsultasi gizi dan lain-lain.
- 3) Instalasi Dapur Gizi (lisan tertulis dalam amplop makanan)
- 4) Kepala ruangan atau penanggungjawab ruangan melaporkan kejadian pasien kabur melalui telepon disusul laporan tertulis kronologis kejadian kepada:
 - a. MPP
 - b. Dokter penanggung jawab pasien
 - c. Kepala bidang perawatan.
 - d. Sub.Bag.Administrasi pasien (AP) dengan melampirkan data yang belum masuk :
 - 1) Pemakaian obat dan Alkes habis pakai
 - 2) Jasa dokter
 - 3) Pemeriksaan penunjang
- 5) Segera :
 - a. Mencari alamat pasien yang bersangkutan
 - b. Membuat berita acara pasien kabur
 - c. Memberitahukan kejadian tersebut kepada bagian Keuangan untuk melakukan penagihan ke alamat yang ada.

6.6 Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PMRJ)

A. Pengertian

Untuk pasien rawat jalan yang membutuhkan asuhan yang kompleks atau diagnosis yang kompleks dibuat catatan tersendiri Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) dan tersedia untuk PPA.

Jika rumah sakit memberikan asuhan dan tindakan berlanjut kepada pasien dengan diagnosis kompleks dan atau yang membutuhkan asuhan kompleks (misalnya, pasien yang datang beberapa kali dengan masalah kompleks, menjalani tindakan beberapa kali, datang di beberapa unit klinis, dan sebagainya) maka kemungkinan dapat bertambahnya diagnosis dan obat, perkembangan riwayat penyakit, serta temuan pada pemeriksaan fisis. Oleh karena itu, untuk kasus seperti ini harus dibuat ringkasannya. Sangat penting bagi setiap PPA yang berada di berbagai unit yang memberikan asuhan kepada pasien inimendapat akses ke informasi Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) tersebut.

B. Informasi Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMJ)

Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) memuat informasi, termasuk :

- 1) Identifikasi pasien yang menerima asuhan kompleks atau dengan diagnosis kompleks (seperti pasien di klinis jantung dengan berbagai komorbiditas antara lain DM tipe 2, *total knee replacement*, gagal ginjal tahap akhir, dan sebagainya. Atau pasien di klinis neurologik dengan berbagai komorbiditas).
- 2) Identifikasi informasi yang dibutuhkan oleh para dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang menangani pasien tersebut
- 3) Menentukan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa informasi medis yang dibutuhkan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) tersedia dalam format mudah ditelusur (*easy-to-retrieve*) dan mudah di-review.
- 4) Evaluasi hasil implementasi proses untuk mengkaji bahwa informasi dan proses memenuhi kebutuhan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan meningkatkan mutu serta keselamatan pasien

Isi minimal formular PRMRJ meliputi :

1. Tanggal dan jam
2. Dokter spesialis
3. Diagnosis penting
4. Uraian klinis penting
5. Rencana penting
6. Remarks
7. Tanda tangan atau paraf
8. Lembar PRMRJ harus berwarna beda
9. Kriteria PRMRJ diagnosis lebih dari satu / kronis di isi oleh DPJP



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA

(Etiket Pasien)

PROFILE RINGKASAN MEDIS RAWAT JALAN (PRMRJ)

Petunjuk Pengisian:

Identifikasi pasien yang menerima asuhan kompleks atau dengan diagnosis kompleks (seperti pasien di klinis jantung dengan berbagai komorbiditas antara lain DM tipe 2, total knee replacement, gagal ginjal tahap akhir, dsb.
Atau pasien di klinis neurologik dengan berbagai komorbiditas).

NO.	TANGGAL	JAM	CATATAN INFORMASI MEDIS	NAMA/ TTD DPJP

BAB VIII

TRANSPORTASI

7.1 Transportasi

A. Pengertian

Proses merujuk, memindahkan, dan memulangkan pasien membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan transpor pasien. Misalnya, pasien dari unit pelayanan kronik atau pusat rehabilitasi yang membutuhkan pelayanan rawat jalan atau evaluasi asuhan di unit darurat mungkin tiba dengan ambulans atau transportasi lainnya. Setelah selesai, pasien mungkin minta bantuan transpor untuk kembali ke rumahnya atau fasilitas lain. Pada situasi lain, misalnya pasien mengemudi kendaraannya sendiri menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan yang kemudian karena tindakan tadi mengganggu kemampuannya mengemudi sendiri untuk pulang (seperti, operasi mata, prosedur yang memerlukan sedasi dan sebagainya). Merupakan tanggung jawab rumah sakit melakukan asesmen kebutuhan transpor pasien dan memastikan pasien mendapat transportasi aman. Bergantung pada kebijakan rumah sakit dan peraturan perundang-undangan apakah ongkos transpor dapat atau tidak menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Jenis kendaraan untuk transportasi berbagai macam, mungkin ambulans atau kendaraan lain milik rumah sakit atau berasal dari sumber yang diatur oleh keluarga atau teman. Jenis kendaraan yang diperlukan bergantung pada kondisi dan status pasien.

Kendaraan transportasi milik rumah sakit harus tunduk pada peraturan perundangan yang mengatur tentang kegiatan operasionalnya, kondisi, dan perawatan kendaraan. Rumah sakit mengidentifikasi kegiatan transportasi yang berisiko terkena infeksi dan menentukan strategi mengurangi risiko infeksi. Persediaan obat dan perbekalan medis yang harus tersedia dalam kendaraan bergantung pada pasien yang dibawa. Misalnya, membawa pasien geriatri dari unit rawat jalan pulang ke rumahnya sangat berbeda dengan jika harus transfer pasien dengan penyakit menular atau transpor pasien luka bakar ke rumah sakit lain.

Jika rumah sakit membuat kontrak layanan transportasi maka rumah sakit harus dapat menjamin bahwa kontraktor harus memenuhi standar untuk mutu dan keselamatan pasien dan kendaraan. Jika layanan transpor diberikan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, perusahaan asuransi, atau organisasi lain yang tidak berada dalam pengawasan rumah sakit maka masukan dari rumah sakit tentang keselamatan dan mutu transpor dapat memperbaiki kinerja penyedia pelayanan transpor.

Dalam semua hal, rumah sakit melakukan evaluasi terhadap mutu dan keselamatan pelayanan transportasi. Hal ini termasuk penerimaan, evaluasi, dan

tindak lanjut keluhan terkait pelayanan transportasi.

Ambulan sebagai sarana transportasi di sebuah pasien rumah sakit sangatlah penting baik itu rumah sakit berskala besar atau kecil.

Rumah sakit Prima Husada sebagai salah satu pemberi jasa pelayanan kesehatan pada masyarakat di wilayah kabupaten Pasuruan juga memiliki ambulan yang digunakan sebagai sarana transportasi pasien dari dan ke luar rumah sakit Prima Husada. Fungsi ambulan sebagai sarana transportasi pasien di rumah sakit harus dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan pasien sampai ketempat yang dituju. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas ambulan harus dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelayanan ambulans adalah suatu prosedur pemindahan pasien dengan menggunakan kendaraan pelayanan medis yang memiliki fasilitas yang lengkap dan didampingi oleh perawat atau dokter yang mampu menangani keadaan gawat darurat untuk tujuan pemeriksaan penunjang, tindakan medis dan alih rawat ke rumah sakit lain.

Sarana Transportasi Medik adalah kendaraan untuk pemindahan pasien atau jenazah dari suatu tempat ke tempat lain.

Ambulans adalah mobil khusus untuk melakukan transportasi medik ke luar rumah sakit memindahkan pasien masuk ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.

Ambulans Jenazah adalah mobil khusus yang hanya digunakan untuk membawa jenazah ke luar rumah sakit

B. Tatalaksana Transportasi

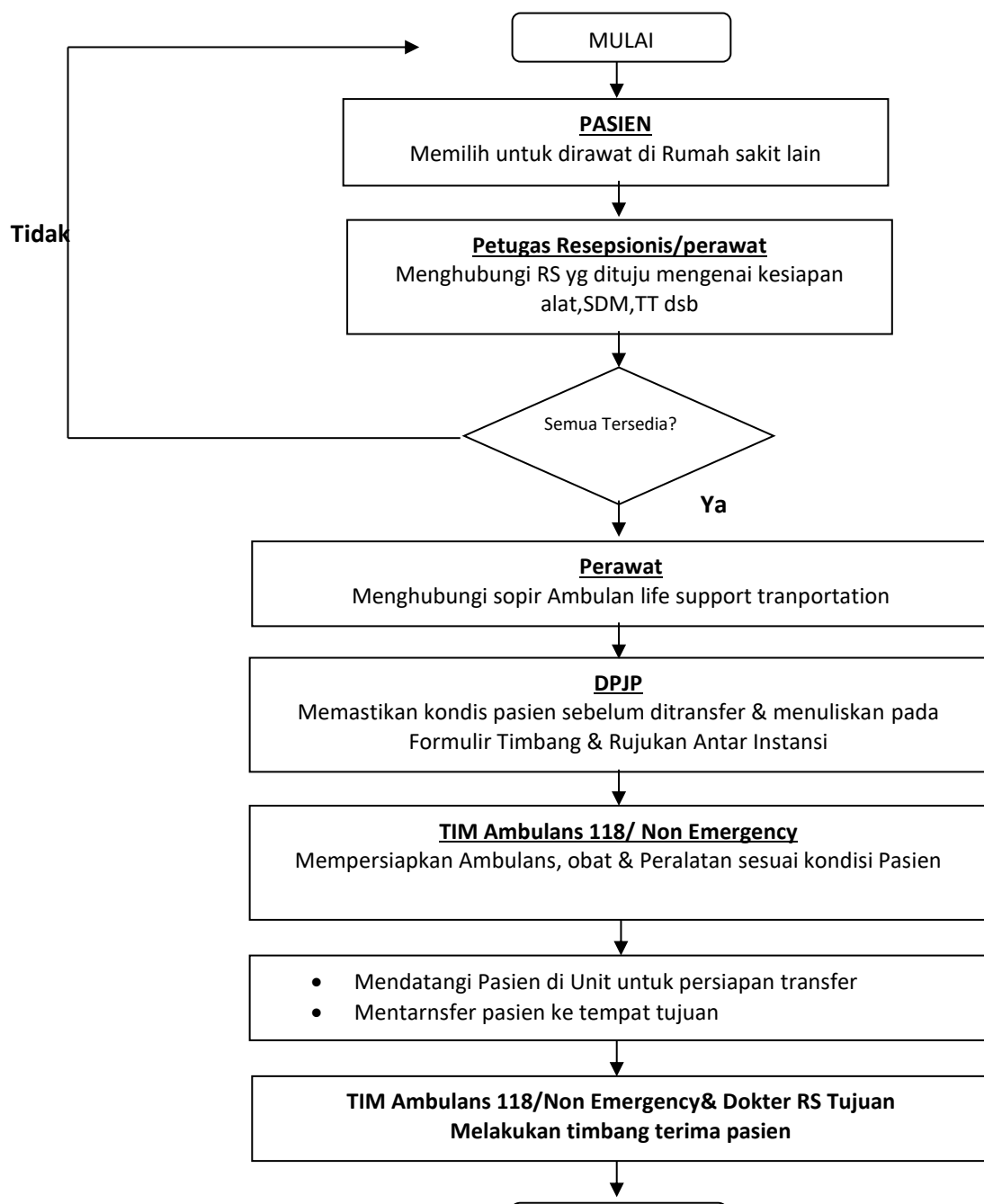
Tatalaksana Transportasi Pasien :

- 1) Permintaan ambulance transfer / rujuk H-1
 - a) Unit mengisi form permintaan ambulance
 - b) Form permintaan ambulance dibawa keluarga pasien ke kasir
 - c) Kasir menstempel tanda lunas di form permintaan ambulance memberikan ke keluarga pasien
 - d) Form permintaan ambulance diserahkan keluarga ke unit
 - e) Unit menyerahkan form permintaan ambulance ke pos 7b
 - f) Saat akan digunakan mengantar pasien, driver memberikan form ke IGD
- 2) Permintaan ambulance untuk transfer / rujuk cito
 - a) Unit mengisi form permintaan ambulance dan menghubungi bagian IGD permintaan ambulance
 - b) Petugas IGD menghubungi pengemudi ambulance yang sedang berjaga
 - c) Form permintaan ambulance dibawa keluarga pasien ke kasir
 - d) Kasir menstempel tanda lunas di form permintaan ambulance dan memberikan ke keluarga pasien
 - e) Form permintaan ambulance diserahkan keluarga ke unit

-
- f) Unit konfirmasi pengemudi ambulance kalau semua sudah siap
 - g) Perawat mengantar pasien ke ambulance
 - h) Perawat IGD memberikan form permintaan ambulance, mencatat di buku permintaan ambulance dan mengambil peralatan ambulance
 - i) perawat mengingatkan keluarga untuk mengisi kuesioner
 - j) pengemudi memberikan kuesioner ke bagian pengelolaan pelanggan setelah kembali dari pengantaran
 - k) Persyaratan kendaraan transfer / rujuk
- 3) Teknis
- a) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak
 - b) Ruang pasien mudah mencapai dari tempat pengemudi
 - c) Tempat duduk bagi petugas di ruang pasien
 - d) Dilengkapi sabun pengaman
 - e) Ruang pasien cukup luas untuk sekurang-kurangnya dua steker
 - f) Gantungan infus terletak sekurang-kurangnya 90 cm diatas tempat pasien
 - g) Stop kontak khusus untuk 220 volt DC diruang pasien
 - h) Lampu ruangan secukupnya
 - i) Lemari obat dan peralatan
 - j) Sirine satu nada
 - k) Lampu rotator warna merah, biru (biru masih dalam proses pelepasan)
 - l) Persyaratan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku
 - m) Tanda pengenal ambulance transportasi dari bahan yang memantulkan sinar
 - n) Buku petunjuk pemeliharaan semua alat berbahasa indonesia
- 4) Medis
- a) Tabung oksigen dengan peralatannya
 - b) Box emergency
 - c) Monitor
- 5) Petugas
- a) Satu pengemudi dengan kemampuan P3K dan komunikatif
 - b) Satu perawat dengan kemampuan PPGD
- 6) Tata tertib
- a) Selama mengangkut pasien hanya boleh menggunakan lampu rotator (untuk pasien pulang / APS tanpa lampu rotator)
 - b) Semua perlengkapan lalu lintas harus di taati
 - c) Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
 - d) Kecepatan kendaraan setinggi 40 km/jam di jalan biasa dan 80 km/jam di jalan bebas hambatan
- 7) Persyaratan ambulance jenazah
- a) Teknis
 - (1) Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak
 - (2) Brangka dilengkapi sabuk pengaman
 - (3) Sirine satu atau dua nada
 - (4) Lampu rotator warna merah dan biru
 - (5) Ruang jenazah terpisah dari ruang pengemudi

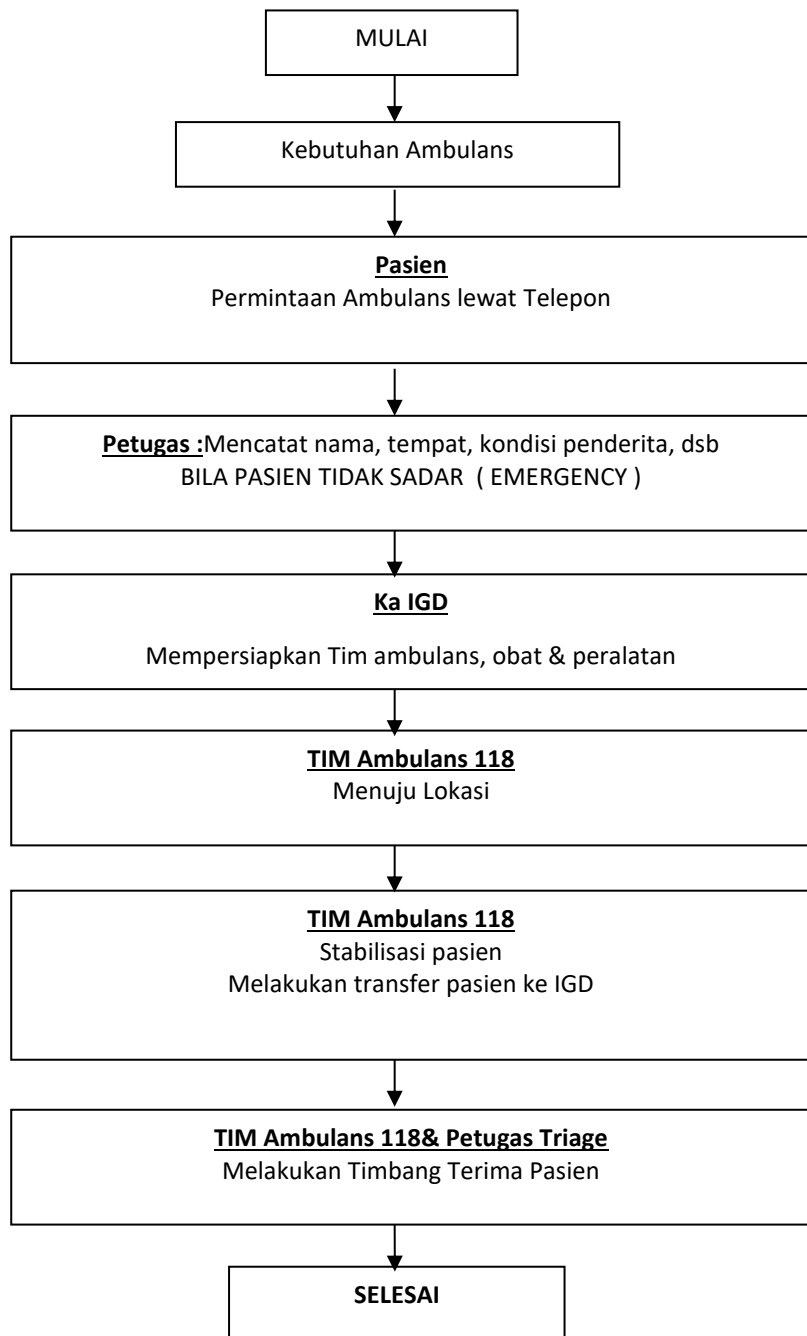
- (6) Tempat duduk atau duduk lipat minimal empat orang disamping jenazah
- (7) Air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah
- (8) Tanda pengenal ambulance atau kereta jenazah dari bahan yang memantulkan sinar
- (9) Persyaratan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- b) Petugas → satu pengemudi yang komunikatif
- c) Tata tertib
 - (1) Sirine hanya digunakan saat bergerak dalam iringan jenazah dan mematuhi peraturan lalu lintas tentang konvoi
 - (2) Apabila tidak dalam iringan hanya boleh menghidupkan lampu rotator
 - (3) Semua perlengkapan lalu lintas harus di taati
 - (4) Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
- d) Kecepatan kendaraan setinggi 40 km/jam di jalan biasa dan 80 km/jam di jalan bebas hambatan

1. Tranfer Pasien Keluar RS. Prima Husada

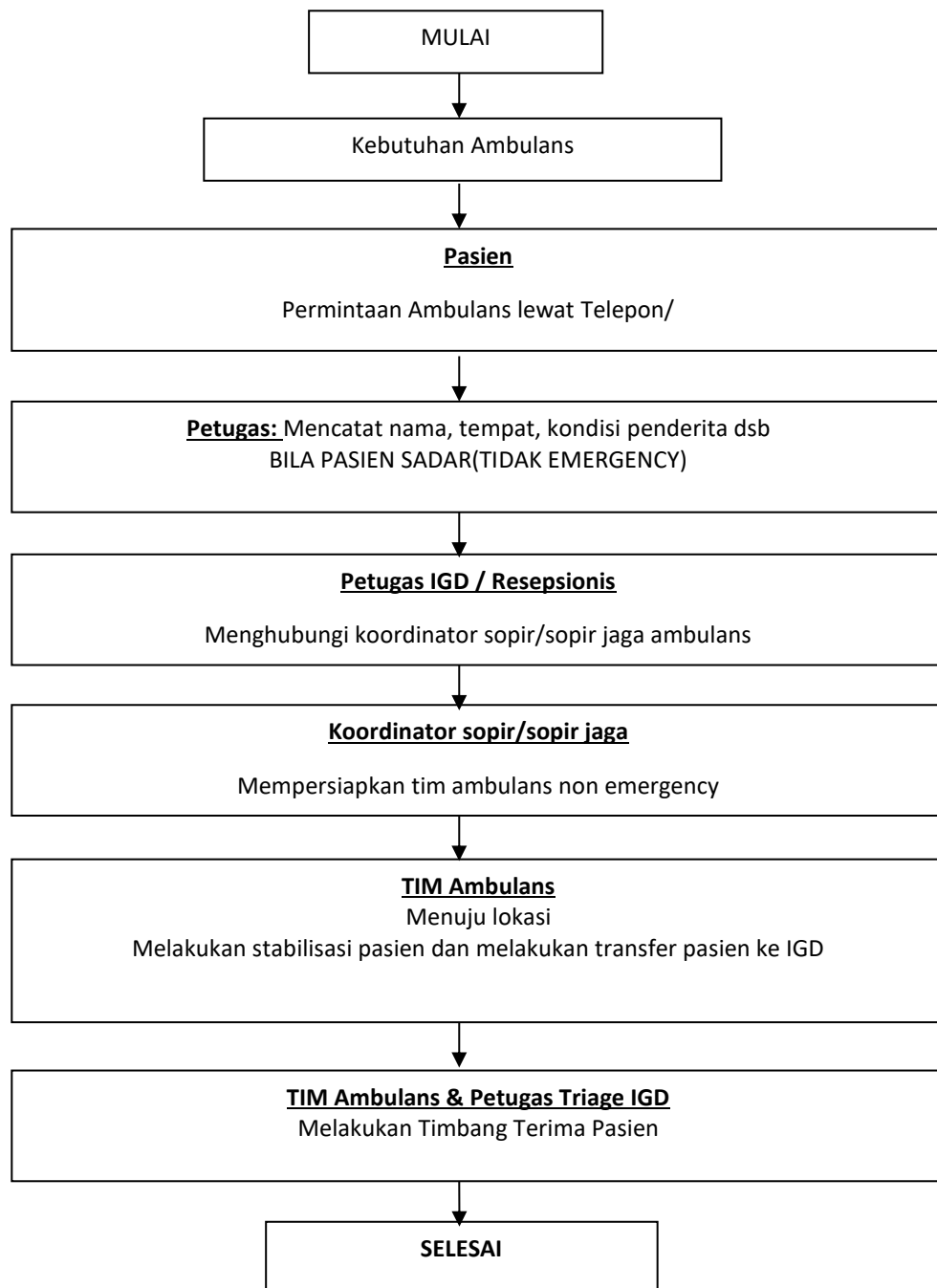


2. Transfer pasien ke dalam RS Prima Husada

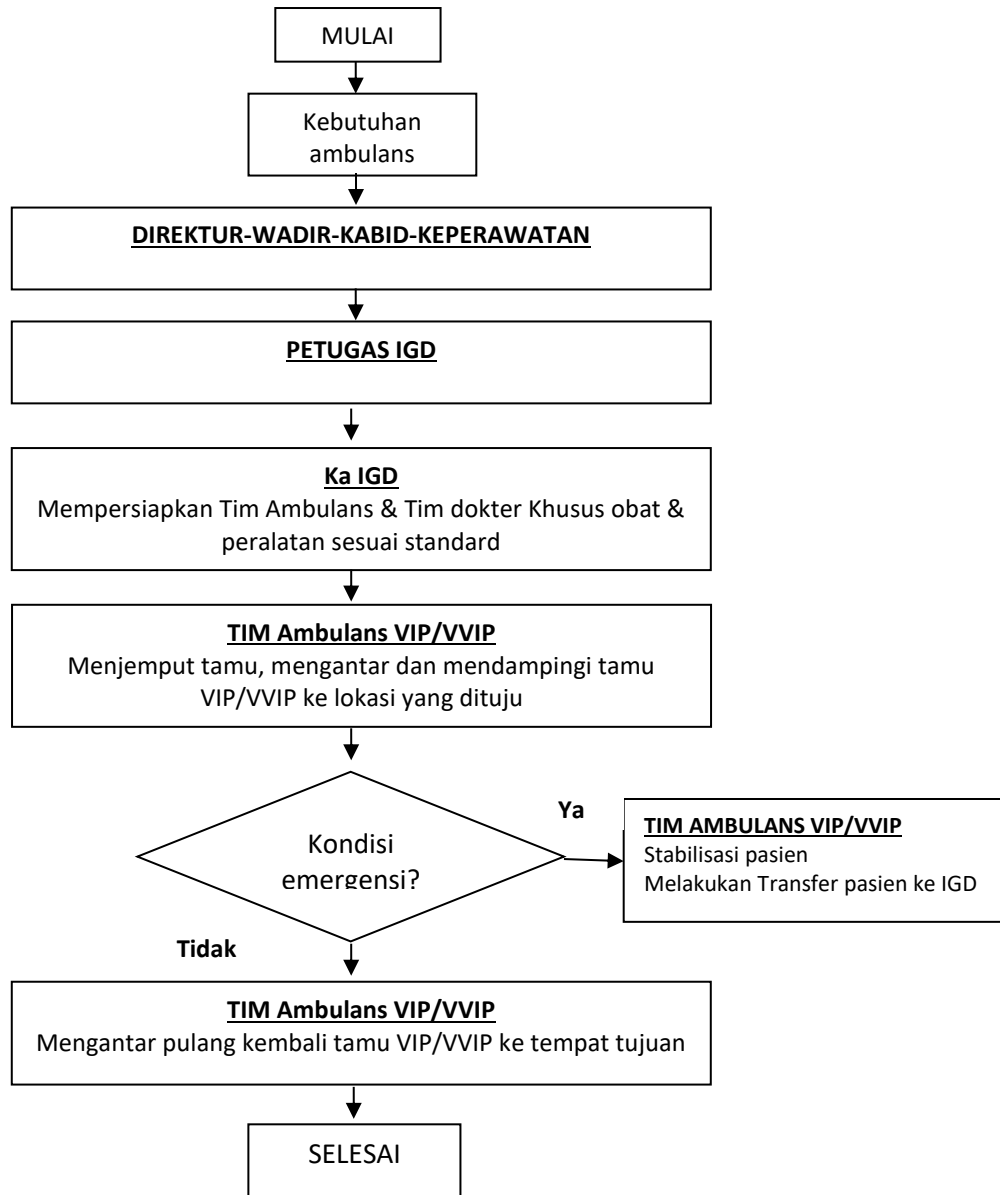
Pasien yang membutuhkan jasa ambulans 118 dapat menghubungi melalui pesawat telepon



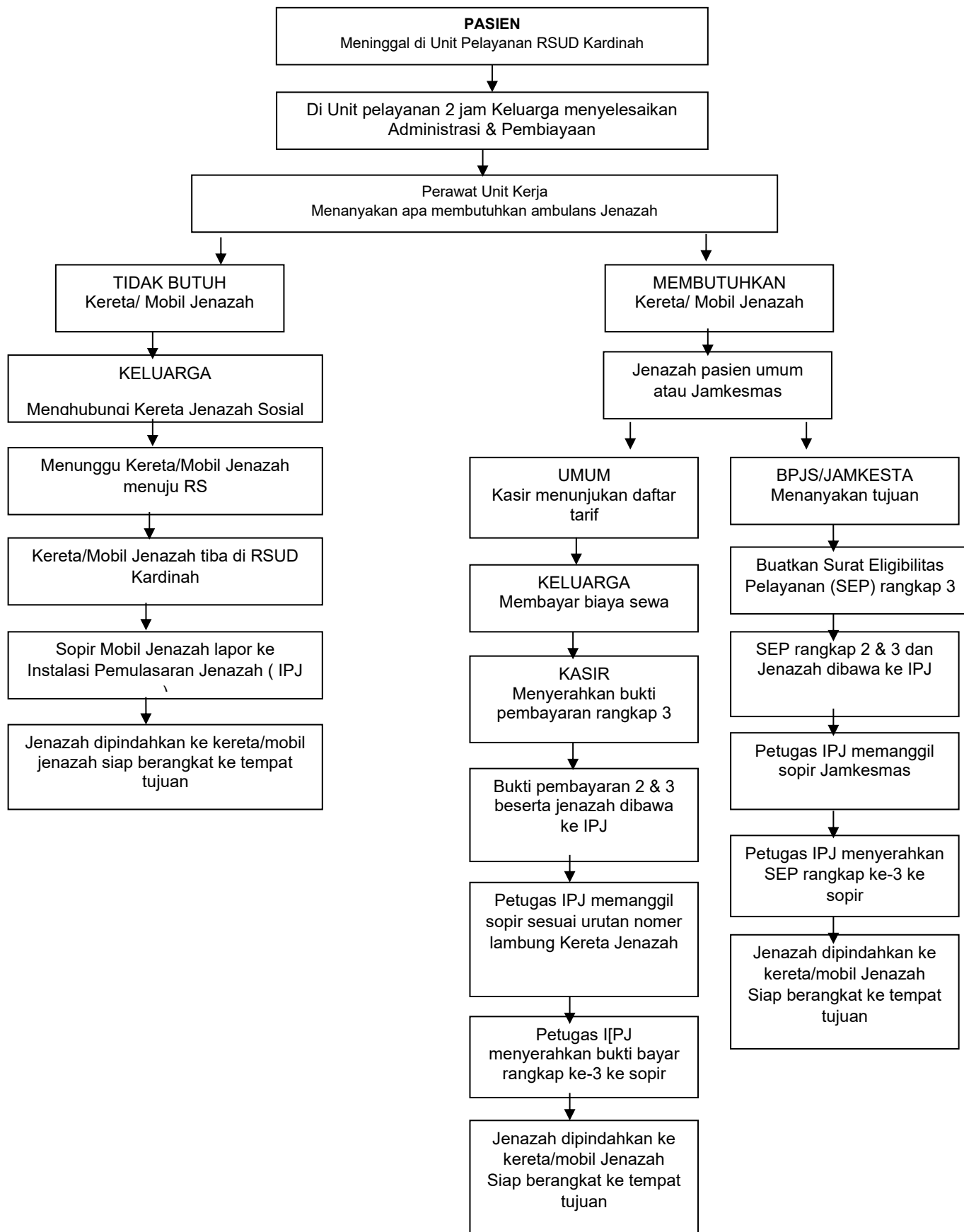
Ambulance non emergency



Skema Alur Siaga VVIP/ VIP



Skema Alur Pelayanan Transportasi Jenazah



BAB IV PENUTUP

Demikianlah buku Panduan Akses Kesenambungan Pelayanan Rumah Sakit ini disusun. Kami mengajak semua pihak yang bekerja di RS Prima Husada untuk dapat bersama-sama membina dan mengembangkan sistem pelayanan yang berkesinambungan ini. Semua petugas baik tenaga medis, paramedis, maupun non medis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan hendaknya selalu menaati ketentuan yang telah digariskan di dalam buku panduan ini.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal, 04 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah